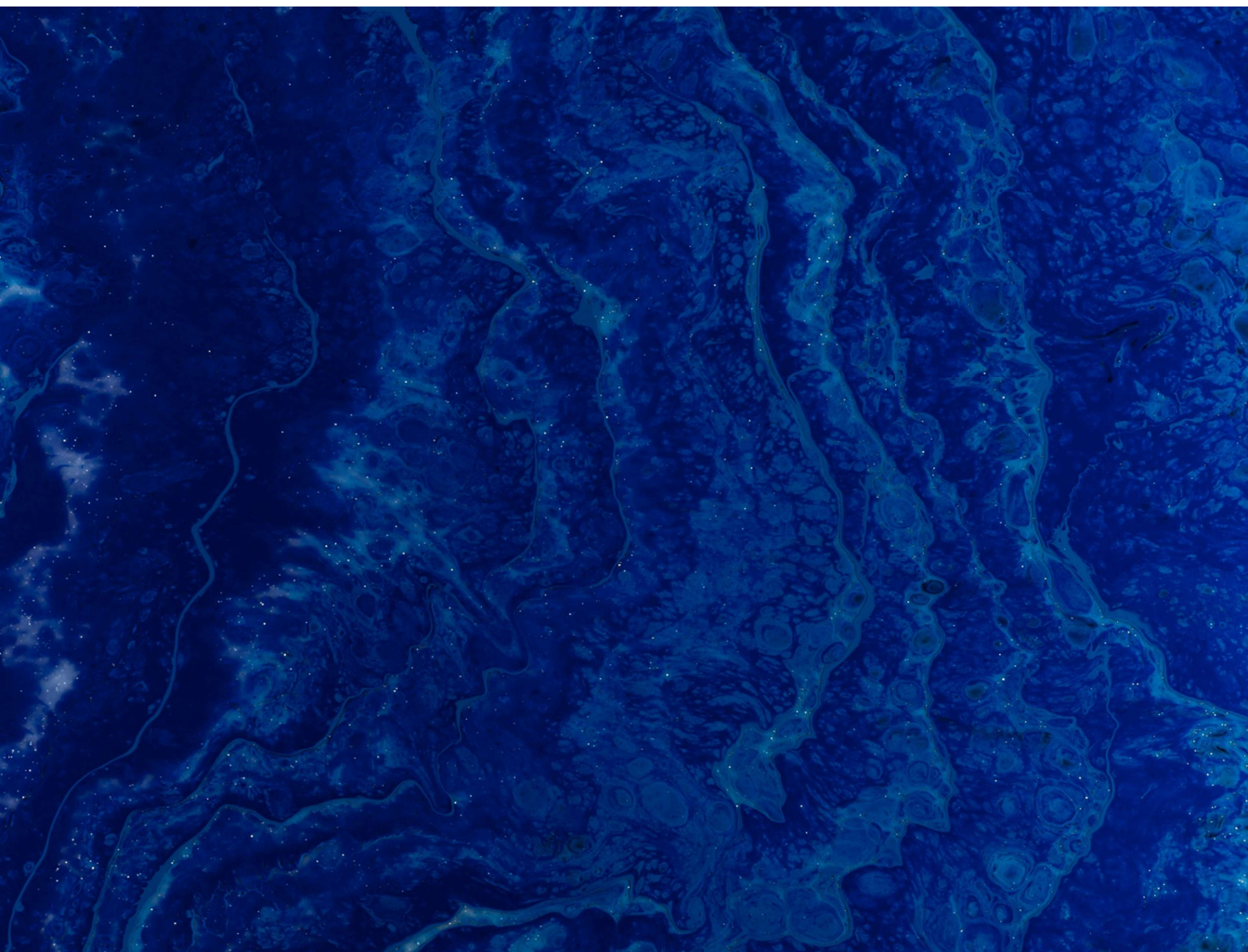


# ZAINTZA DIAGNOSTIKO PARTEKATUA

**Gernika-Lumoko Zaintza Mahaia**

**2025eko abendua**



# AURKIBIDEA

|    |                                                                                                        |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | SARRERA.....                                                                                           | 1  |
| 2  | PROZESUAREN NONDIK NORAKOAK.....                                                                       | 2  |
|    | 2.1. Printzipio gidariak.....                                                                          | 2  |
|    | 2.2. Helburuak.....                                                                                    | 3  |
|    | 2.3. Emandako pausoak eta parte-hartzaileak.....                                                       | 4  |
| 3  | DIAGNOSTIKOA.....                                                                                      | 8  |
|    | 3.1. Zaintzaren gaineko begirada.....                                                                  | 8  |
|    | 3.2. Gernika-Lumoko adinekoen eta dibertsitate funtzionala duten<br>pertsonek zaintza-ekosistema ..... | 10 |
|    | 3.2.1. Datu orokorrak.....                                                                             | 12 |
|    | 3.2.2. Zaintza-lanen balioa.....                                                                       | 15 |
|    | 3.2.3. Zainduak diren pertsonen egoera eta zaintza-beharrekin lotutako<br>bizipenak .....              | 17 |
|    | 3.2.4. Zaintzaileen egoera eta zaintza-ardurek dakartzaten bizipenak.....                              | 21 |
|    | 3.2.5. Zerbitzu publikoen eta programen argazki kualitatibo bat .....                                  | 26 |
|    | 3.2.6. Zaintzaren dimentsio komunitarioa eta herriaren antolaketa .....                                | 38 |
| 4. | GERNIKA-LUMOKO ZAINZA-EKOSISTEMA: ONDORIOAK ETA<br>ERRONKAK .....                                      | 40 |
| 5. | ERANSKINAK.....                                                                                        | 45 |
|    | E.1. Zaintza mahaiaren rola .....                                                                      | 45 |
|    | E.2. Proposamenak .....                                                                                | 46 |

## 1 SARRERA

Gernika-Lumoko Zaintza-mahaia 2023ko udazkenean sortu zen, azaroaren 30eko Greba Feminista Orokorren ondoren gernikarrek eginiko herri-akordioan, adostutako ekimenak egikaritzeko egitura gisa. Egitura honetan Udalak, bertako alderdi politiko guztietako ordezkariak, sindikatuak, pentsiodunen mugimenduko ordezkariak eta Gernikako Sare feministak hartzen dute parte.

Zaintza-mahaiak hasi berri duen bide horretan lehengo erronka, zaintza-egoeraren ezagutza sakonagoa eta partekatua izatea da. Horretarako, Gernika-Lumoko Zaintza Mahaiak herriko zaintza egoeraren diagnostiko partekatua egitea adostu zuen, eta hala egin du azken hilabeteetan Elhuyarren laguntzarekin.

Orriotan jasotzen da egindako prozesuaren berri, bai eta egindako gogoeten zein ateratako ondorioen berri ere. Diagnostiko hau abiapuntua izango da herrian hurrengo urteetan zaintzaren alorrean egingo diren urratsak irudikatzen hasteko.

## 2 PROZESUAREN NONDIK NORAKOAK

Atal honetan prozesuaren nondik norakoak jaso ditugu; izan ere, prozesuaren nolakotasunak diagnostikoaren izaera baldintzatu du. Hau izan da Gernika-Lumoko Zaintza mahaia adostu eta aurrera eraman duen bidea.

### 2.1. Printzipio gidariak

Prozesuak hainbat printzipio izan ditu oinarrian, egindako lanak eta hartutako erabakiak gidatu dituztenak. Printzipio hauek Zaintza mahaian adostuak izan dira, eta ikuspegi honetan zentratzen da diagnostikoaren baitan egindako irakurketa.

- **Prozesua paradigma feminista batetik abiatzea**, Euskadiko marko estrategikoan (Berdintasunerako Plan Estrategikoa 2030) jasotzen den printzipio moduan.

Prozesua Paradigma Feministatik abiatzeak esan nahi du Gernika-Lumoko zaintzaren inguruko azterketa, pentsamendu, teoria eta praktika feministek eskaintzen dizkiguten askotariko lerro eta dimentsioak aintzat hartzea. Hala nola, harremanen, identitateen eta bizitzen oinarrian gailentzen diren zapalkuntza, genero-rol eta -estereotipoak ulertu eta azalera ateratzeko marko bat ematen digu. Gainera, paradigma feministatik eraldaketa sozialerako eta errealitate ezberdinak interpretatu eta teorizatzeko ekarpen handia egiten ari da une historiko-politiko honetan. Beraz, paradigma feminista oinarri izateak esan nahi du teoria feminista eta feminismoetatik egindako ekarpenak aintzat hartuko direla eta arrazoiak oinarri izango direla.

- **Genero-ikuspegia lanerako metodologia gisa harturik lan egitea**, Nazio Batuen Erakundeak 1995ean Beijing-eko adierazpenean definitu zuen moduan ulertuta. Honela bada, genero-ikuspegia mendekotasun patriarkalean oinarritutako genero desberdintasunak agerian jartzeko baliatuko da. Honela bada, sistematikoki kontuan izango ditugu genero-erolek sortzen dituzten egoera, baldintza, jomuga eta beharrian diferentek, eta horiek pertsonengan dituzten inpaktu eta ondorioak. Kasu honetan, adibidez, zaintza lanen feminizazioa izango da aintzat hartuko den alderdietako bat analisisa egiterakoan. Hau da, nahiz eta uneoro aipatuko ez den, presente egongo da analisisan zaintza lan profesional zein ez-profesionalak egiten dituzten pertsona gehienak emakumeak direla.
- **Ikuspegi intersektionala ardatz izatea**, Genero-berdintasunerako Europako Estrategiaren printzipioak markatzen duen moduan.

Genero-ikuspegiaren ikuskera konplexu eta integralago batetik, Gernika-Lumoko zaintzaren diagnostikoa egiteko prozesuak generoaz gain, bestelako diskriminazio faktoreekin duen aldibereko erlazioa ere aintzat hartuko du desberdintasunei heltzeko ikuspegi gisa.

Ikuspegi honi esker ezaugarri ezberdinek pertsona bakoitza nola gurutzatzen duten ulertuko dugu. Izan ere, zeharkatzen gaituzten eta elkar eragiten duten diskriminazio- eta desberdinkeria-iturriak askotarikoak izan daitezke: arraza, klase soziala, dibertsitate funtzionala, adina, hizkuntza, orientazio sexuala, identitate sexuala, familia-eredua eta inguruabar pertsonalak eta sozialak.

Hori dela eta, garrantzitsua da ahal den neurrian aldagai horiek guztiak kontuan hartzea datuak jasotzerakoan zein landa lana, elkarrizketak eta azterketak egiterakoan; besteak beste, generoaren kategoria dikotomikoa (emakume/gizon) gainditzeko. Azken batean, pertsona bakoitzak dituen ezaugarriei gizarteak egozten dizkion konnotazio positibo edota negatiboen arabera, modu hierarkiko batean sailkatzen gaitu gizarteak, ezaugarri guzti horien elkarreraginaren ondorioz.

Honela bada, interseksionalitateak berekin dakar ekintza eta aztergai konplexuagoak eta integratzaileagoak proposatzea, zeinak agerian jarriko dituzten emakumeen aurkako desberdinkeriak areagotzen diren egoera horiek guztiak.

## 2.2. Helburuak

Prozesu honen helburu nagusia **gaur egungo egoera ezagutzea** izan da. Gernika-Lumon zaintzen inguruko egoera zein den aztertuko dugu, zein diren egiten diren zaintza-lanak eta nork egiten dituen bereziki. Zein den eskaintza eta eskariaren proiektzioa egitearekin batera.

Horrez gain, Zaintza mahaiaren etorkizuneko lanerako oso lagungarriak izango diren beste bi azpi-helburu betetzeko ere baliatu dugu prozesua:

1. **Eragileen eta norbanakoen mapa osatzea.** Eragileen mapa lantzea Gernika-Lumon zaintzaren bueltan martxan dauden eragile eta norbanakoen identifikazio ariketa eginez. Bide batez, harreman-sareak identifikatzeko ariketa egin dugu, prozesuan inplikatu ditugun eragile edota norbanako interesgarriak edo gakoak zein diren aztertzeko. Mapa hori begi-bistan dugula, identifikatu ditugu egitasmoan inplikatu nahi izan ditugun pertsonak eta eragileak.
2. **Gogoeta partekatua egitea.** Diagnostikoa osatzeko prozesuan parte hartu duten eragile eta norbanakoen arteko gogoeta partekatua egitea.

Helburu nagusi horiez gain, **zeharkako helburu** hauek ere izan ditu prozesuak:

- Prozesuan parte hartuko duten eragile eta norbanakoek gaiaren inguruko **errealitateaz jabetzea eta eragiteko beharraz sentsibilizatzea.**
- Gernika-Lumoko norbanako eta eragileak euren toki eta arduratik prozesuaren alde zein honen osteko lanketei dagokienez, egin dezaketen ekarpenaz edo eragin dezaketen aldaketaz jabetzea.
- Gogoeta-prozesuaren parte sentiaraztea eta aurrera begira martxan jar daitezkeen ekimenetan parte hartzeko edo gaian eragile aktibo izateko motibatzea.
- Udalaren eta prozesuan parte hartu duten norbanako eta eragileen arteko zubiak indartzea, elkarlanaren ondorioz.



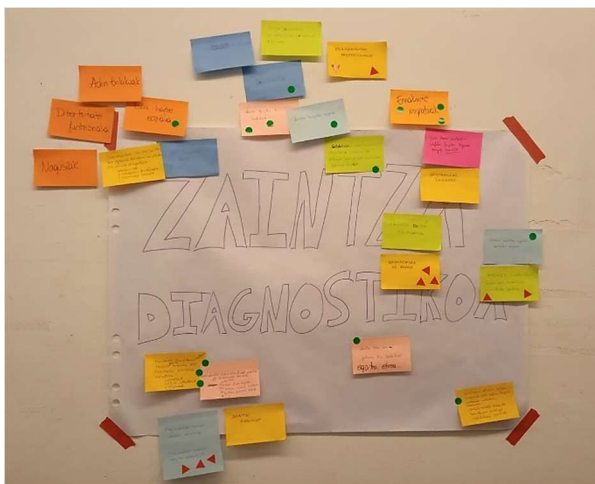
### 2.3. Emandako pausoak eta parte-hartzaileak

Diagnostikoa osatzeko prozesuaren gune nagusia **Zaintza Mahaia** izan da, guztira 4 bilera egin ditu. Marko honek berebiziko garrantzia izan du, bai informatzaileak eta aliatuak bilatzeko, bai eta kontrasteak eta gogoetak egiteko ere.

Hala, 2025eko uztailean abiatu genuen **lau fasetan garatutako prozesua**:

Egitasmoa abiatzeko **Zaintza Mahaiarekin lehenengo bilera** egin genuen, diagnostikoa osatzeko urrats nagusiak adosteko.

Prozesuaren abiapuntu bezala hartu beharreko lehenengo erabakia izan zen zaintzaren zein alderdiri erreparatuko genion diagnostikoan. Izan ere, zaintzak bizitzako alderdi guztiak eta bizi-etapa guztiak hartzen ditu, baina ezinezkoa da guztiei erreparatzea diagnostiko bakar batean. Hori dela eta, fokua non jarriko genuen hautatu behar izan zuen Zaintza Mahaiak, eta lehen urrats honetan **diagnostikoa mendekotasun edo zaurgarritasun egoeran dauden herrikideengan erdiratzea erabaki zuen**.



Zehazki, **adineko pertsonen eta dibertsitate funtzionala duten pertsonen** egoeran arreta jartzea erabaki zen. Era berean, lehenengo unetik adostu zen diagnostiko honen xede izango zela ikusezin geratu ohi den **emakume migratuen errealitatea** islatzea, beraiek baitira zaintza-lanen oinarrian dauden kolektibo garrantzitsuenetako bat. Bestalde, Zaintza Mahairen nahia izan da mendekotasun egoeran dauden adinekoen eta dibertsitate funtzionala duten pertsonak artatzeko **zerbitzu eta programa publikoen erradiografia** osatzea.

Honela bada, kontziente izanik zaintzak badituela beste hainbat erpin ere, hau izan da diagnostiko honetan aztertu dugun errealitatearen parte.



Lehen bilera hartan **Gernika-Lumoko eragileen mapa edo soziograma** osatu genuen. Prozesu honetarako gakoak izan zitezkeen eragile zein norbanakoak identifikatu genituen eta baita haien arteko harremanak eta elkarreraginak ere. Hau da osatutako maparen egitura:

| Zerbitzuak eta programak | Zaintzaileak                            |                  |                           | Zainduak diren pertsonak |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|
|                          | Zerbitzu publikoetan lan egiten dutenak | Etxeko langileak | Familian zaintzen dutenak |                          |

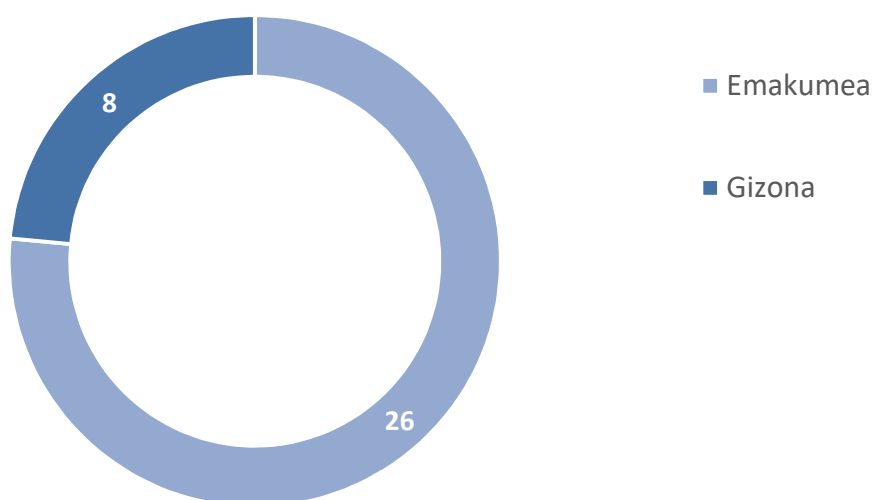
Lan hau egiteak elkarriketen diseinua bera, eta **elkarriketak egiteko** kolektibo eta pertsonak hautatzea erraztu digu; baita prozesu honetarako aliatuak identifikatu eta eragile kualifikatuak identifikatu ere.

Prozesuaren bigarren fasean datu eta dokumentazio-bilketari ekin eta Zaintza Mahaiarekin egindako soziogramaren gainean lan-banaketa antolatzeari ekingo diogu.

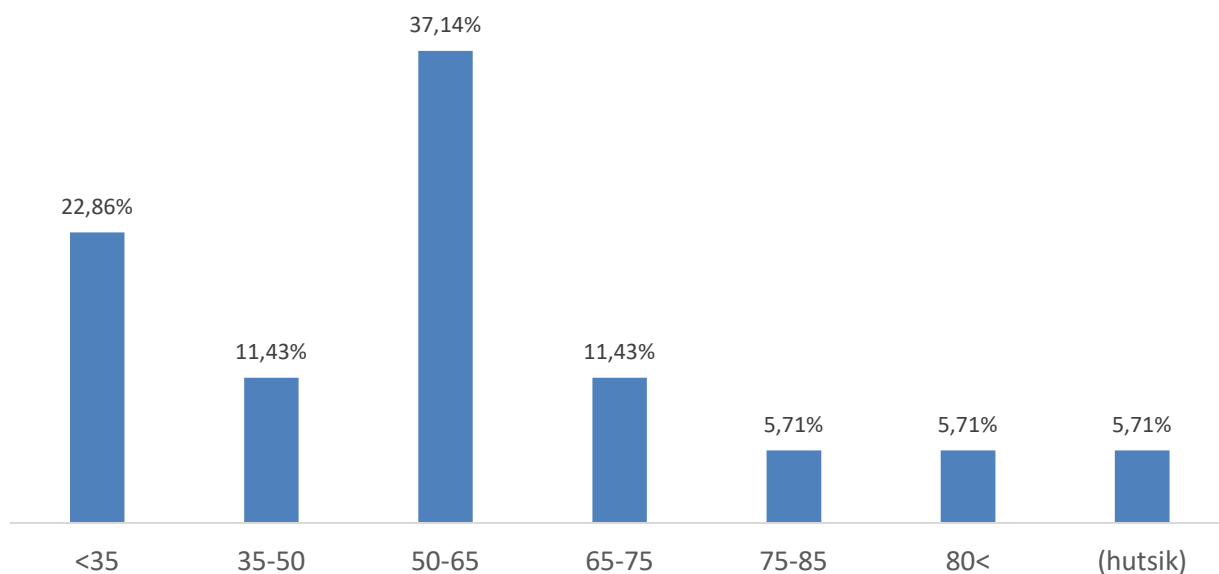
Prozesuaren **talde-sustatzailea** izendatu dugunak protagonismo berezia izan du bigarren fase honetan: izan ere, Zaintza Mahaiko 5 kidek osatutako taldeak elkarriketak egin ditu Elhuyarrekin batera. Horrek informazio bilketak dimentsio handiagoa izatea ahalbidetuko du.

**Talde sustatzailearekin bi lan-saio** egin ditugu: lehena trebakuntza gisa, elkarriketetarako gidoiak eta informazioa jasotzeko tresna lantzeko eta talde-sustatzaileko kideak trebatzeko, zelan jardun ezagutu eta denok era koherentean aritzeko. Bilera horretan, gainera, bakoitzak zer elkarriketa egingo zituen ere antolatu genuen. Kide bakoitzak hiru bat elkarriketa egingo zituela adostu genuen, eta gainontzekoak Elhuyarren gain geratuko zirela. Bigarren saioan, elkarriketek emandakoa kontrastatu genuen eta ohar eta bizipenak partekatu.

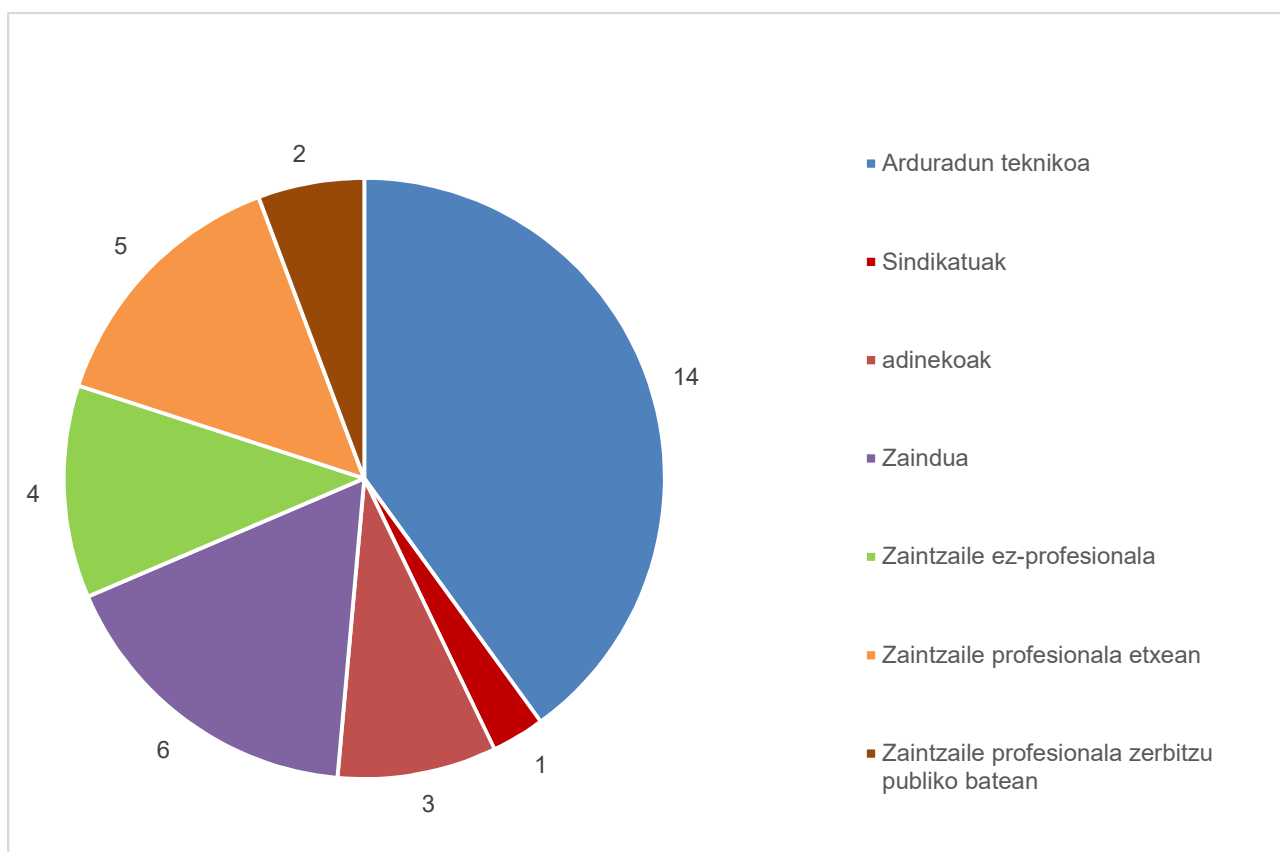
Guztira **23 elkarriketa** egin ditugu banaka edo taldeka; eta hala, **34 lagun elkarriketatatu ditugu**: Hauetatik % **76,5 emakumeak** izan dira. Jatorriari dagokionez, elkarriketatuen % **80k Bizkaian du jaioterria** eta % **8,6k Europar Batasunetik kanpo**.



Adinari erreparatuta, **elkarrizketatu gehienak 50 eta 65 urte bitarteko** tartean kokatzen dira baina **gazteen zein adinekoen presentzia ere bermatu dugu**. Izan ere, elkarrizketatuen % 22,8 35 urtetik beherako gazteak izan dira, eta beste horrenbeste 65 urtetik gorako pertsonak izan dira.



Azkenik, elkarrizketatuen profilari begiratuta ere, **aniztasuna** lortu dela ikusiko dugu, nahiz eta zerbitzu publikoetako edo diru publikoz lagundutako programen **arduradun teknikoekin egindako** elkarrizketa-kopurua handiagoa izan den.





Informazio-bilketarekin bukatutakoan edukien azterketari ekin diogu eta Zaintza Mahaiaren bi saiotan **informazioa kontrastatu, osatu eta aberasteko ariketa kolektibo eta partekatuan** murgildu gara.

Bestalde, saio horietan zaintzaren gaineko begirada edo markoa lantzeko ariketa egin dugu, diagnostikoari oinarri konpartitu batetik eutsi ahal izateko.

Azkenik, saio hauetan diagnostikoa kontrastatzeaz gain, **ondorio batzuk** atera eta adosteko ahalegina egingo dugu eta ariketa osoaren emaitza da jarraian dagoen diagnostikoa.

Prozesua amaitzeko, behin txostena osatuta, azken bilera bat egin du Zaintza Mahaiak, emaitzari azken ekarpenak egin eta prozesua baloratzeko. Azken bilera honetan hurrengo urratsez jarduteko tarte bat ere hartu dugu.

### 3 DIAGNOSTIKOA

Arestian aipatu bezala, Gernika-Lumon bizi eta lan egiten duten askotariko pertsonen iritziak, bizipenak eta ekarpenak ekarri ditugu diagnostiko honetara eta, funtsean, haiekin egindako sakoneko elkarriketen emaitza da datozen ataletan jaso duguna. Hala ere, zaintza-krisia egiturazkoa den heinean, bertan bildu ditugun faktoreetako asko herriaren mugak gainditzen dituzten joera orokorrei erantzuten diete.

Gauzak horrela, Zaintza Mahaiaren helburuetako bat izan da Gernika-Lumoko eta eskualdeko faktore bereizgarrietan azpimarra jartzea, auziaren dimentsio globala ahaztu gabe; eta halaxe, begirada bikoitz horretatik dago eraikita datozen orrialdeetan jaso dugun diagnostikoa.

Bestalde, sarreran aipatu dugun bezala, zaintzak bizitzako alderdi eta etapa guztiak hartzen dituela kontuan hartuta, ezinezkoa izan da guztiei erreparatzea esku artean duzun diagnostiko honetan. Hala, lehen urrats gisa, Gernika-Lumoko Zaintza Mahaiak adinekoen eta dibertsitate funtzionala duten pertsonen zaintza errealitatean jarri du arreta. Hain zuzen ere, zaintzaileen zein zainduak diren pertsonen bizipenetan eta beharretan, kolektibo hauei zuzendutako zerbitzuetan eta zaintzaren dimentsio komunitarioari begiratuta. Honela bada, kontziente izanik zaintzak badituela beste hainbat erpin ere, hau izango da diagnostiko honetan aztertuko dugun errealitatearen parte.

#### 3.1. Zaintzaren gaineko begirada

Arestian aipatu bezala Zaintza Mahaian zaintzaren gaineko begirada konpartitu bat lantzeko ariketa egin dugu.

Abiapuntu gisa, **zaintza** bizitzako une eta eremu guztietan da beharrezkoa gizakiok interdependenteak garen heinean, eta hala ulertzen du Zaintza Mahaiak. **Zaintza-beharrez** hitz egiten dugunean, bizitza duin bat izateko beharrezkoak diren zaintzei buruz ari gara. **Zaintza-lanei** buruz hitz egitean, ordea, bizitza sostengatzeko beharrezkoak diren lanez dihardugu.

Zentzu horretan, ongizatea ez da soilik fisikoa, ongizatea emozionala, psikologikoa eta soziala ere bada, eta hori bermatzeko askotariko ekintzak beharrezkoak dira. Honela bada, zaintza ez da mendekotasunarekin eta zaurgarritasunarekin soilik lotuta egongo, nahiz eta dependentziaren bat tarteko dagoenean jaso/eskaini beharreko zaintzak beste dimentsio bat hartzen duen.

Zaintza behar horiek asetzeko ere modu ezberdinak daude. Aurrez esan bezala, gehien bat familia barruan asetu izan dira tradizionalki zaintza beharrak, eta gaur egun ere hala jarraitzen du. Izan ere, gizartean zaintzak ulertzeko eta antolatzeko moduan oso errotuta dago ikuspegi familista eta honen baitan antolatzen dira batik bat zaintza-lanak. Horren ostean, esku-lana zuzenean kontratatzea izaten da hurrengo aukera; eta hirugarrenik, zerbitzu publikoen bidez egitea da (kasu gehienetan ordainketa partekatu bidez), hala dagokizun zerbitzuen bidez.

Edonola ere, modu batera edo bestera izan, emakumeak dira bizitzari eusten diotenak, baldintza eskas eta, maiz, prekarioetan; bai familiaren baitan eta baita profesionalki ere.

Guzti hau ordea, **krisian dagoen sistema baten isla** da. Izan ere, gure testuinguruan operatzen duen zaintza-sistema bidegabea, desorekatua eta mugatua da, eta ez da gai gizartearen beharrak

asetzeko. Bestela esanda, zaintzez hitz egitea kapitalaren eta bizitzaren arteko tentsioaz hitz egitea da gaur egun.

Gure gizartearen zahartzeak ekarritako zaintza beharren gorakadak egoera tentsionatzea eta kasu askotan jasangaitza bihurtzea ekarri du. Testuinguru honetan, zaintza lan horien ardura handiena zuten emakumeek planto egin du eta egoera jasanezina dela aldarrikatu; mugimendu honek egoerak emakumeentzat dakartzan ondorio kaltegarriak ikusaraztea eta zaintza-lanak agenda politiko eta sozialean txertatzea ekarri du.

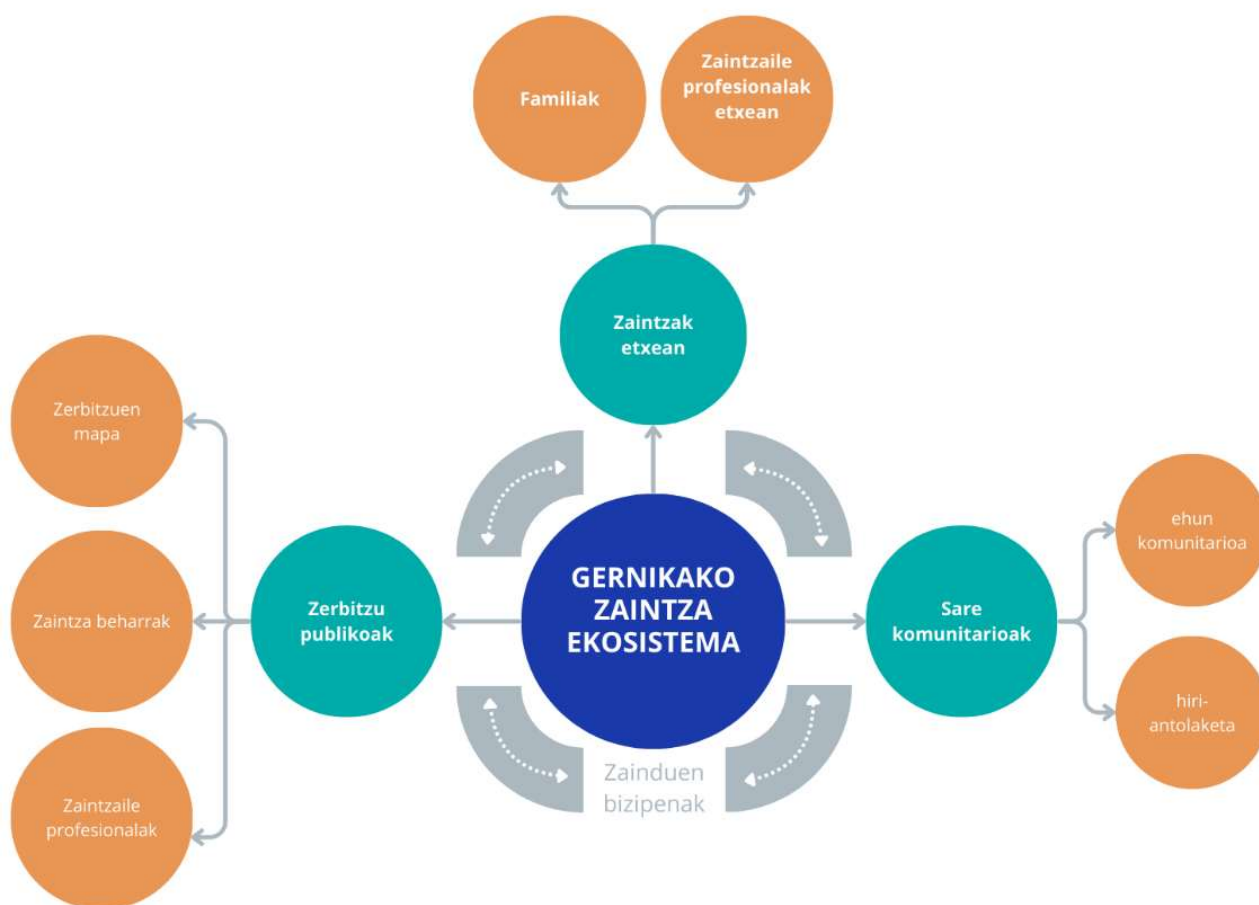
Testuinguru honetan, gero eta gehiago dira zaintza-sistema aldatzeko beharra ikusten dutenak, baina horrek egungo gizarte-antolamendua eraldatzea dakar ezinbestean. Hortaz, **zaintza-lanak antolatzeke eredu-aldaketan sakontzea eraldaketa sozialerako tresna bat da.**

Hortik abiatuta, diagnostikoak komunitateari buruz ere hitz egin behar duela uste dugu Zaintza Mahaian. Izan ere, gauza asko egiten ditugu jada komunitate klabeen, eta hori ere aitortu behar da, bai eta bide horiek eskaintzen dituzten aukeretan sakondu ere.

Komunitateaz aritzea bizitza komunaren logikan eraikitzearen aldeko apustua egitea da, zaintza eskubide eta erantzukizun kolektibo gisa ulertuz. Aitzitik, komunitateak ez du bete behar administrazioek estali gabe uzten duten hori. Izan ere, arlo publikoaren eta komunitarioaren arteko harremana ez da dikotomikoa, eraikuntzan dagoen zerbait baizik.

### 3.2. Gernika-Lumoko adinekoen eta dibertsitate funtzionala duten pertsonen zaintza-ekosistema

Diagnostikoa antolatzeko asmoz **Gernika-Lumoko zaintza-ekosistema** irudikatzeko ariketa egin dugu Zaintza Mahaian. Alegia, herrian zaintza-lanak ikuspegi integral batetik nola antolatzen diren erakusteko ahalegina egin dugu. Honela, modu bisualean jaso dugu Gernikako zaintza ekosistemaren eskema.



*Irudian: Zaintza Mahaian osatutako eskema.*

Erdigunean, **zaintza-ekosistemaren muina** dugu, zaintza ez dugulako ekintza isolatu bat eta bakar gisa ulertzen, herri-mailako sistema bizi eta konplexu gisa baizik. Erdigune horretatik hiru adar nagusi ateratzen dira, ekosistema hori nola egituratzen den azaltzen dutenak:

**Zaintzak etxean** (goian), zaintza-lanen esparru pribatuari dagokion ardatza da. Bertan kokatu ditugu, batetik, familiak (gehienak senideak dira baina gertuko zaintzaile ez profesionalak ere izan daitezke, bestelako sareak eraikitzen diren kasuetan); eta bestetik, etxeetan lan egiten duten zaintzaile profesionalak (etxeko langileak, erregimen internoan lan egiten dutenak zein orduka dabilzanak).

**Zerbitzu publikoak** (ezkerrean), erakunde eta administrazio publikoek eskaintzen duten sarea izango litzateke. Ardatz honetan aztertu dugu eskuragarri dauden zerbitzu eta baliabideen katalogoa edo mapa, kontuan izanda, batetik zeintzuk diren herritarren zaintza-behar eta premia errealak, eta bestetik, zein den zerbitzu hauekiko zaintzaile profesionalek duten iritzia eta bizipena. Alegia, erakunde publikoen ardurapeko zerbitzuetan lan egiten duten langileen begirada ere txertatu dugu.

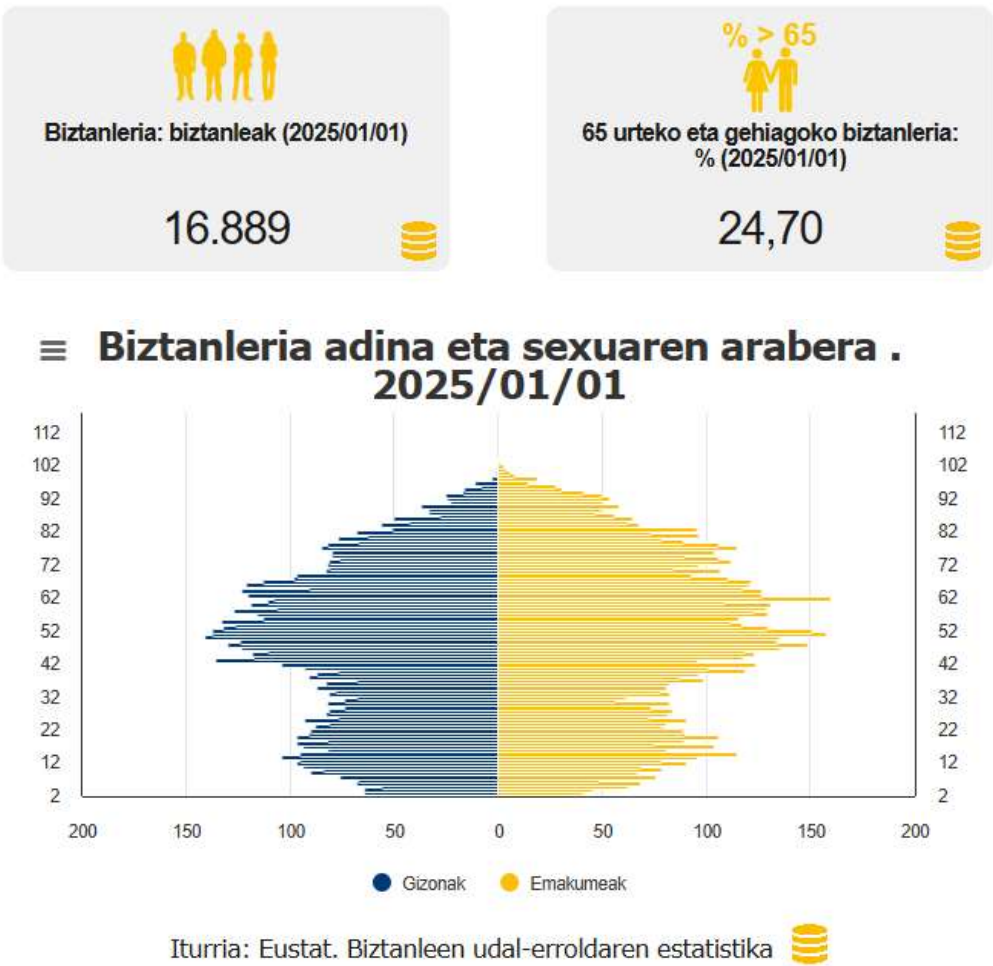
**Sare komunitarioak** (eskuinean) gizarteak eta herri-ereduak berak zaintza-ekosisteman duen papera nabarmendu nahi du. Ardatz honetan barne hartu ditugu, batetik, auzokideen eta elkarteen arteko harreman-sareek osatutako ehun komunitarioa eta bestetik, hiri-antolaketa. Hau da, herria bera nola dagoen diseinatuta zaintzaren ikuspegitik (irisgarritasuna, espazioak, etab.), hau errazteko edo ez.

**Zainduen bizipenak** zeharka agertzen dira zaintza-ekosistema osoa inguratzen; egitura estatiko gisa baino, sistema osoan eta ardatzetako bakoitzean kontuan hartu beharreko elementu gisa.

Horrenbestez, Zaintza Mahaiaren lehen ondorio eta erronketako bat da **Gernika-Lumon zaintza erantzunkidetasunaren ikuspegitik lantzeko beharra eta nahia**. Izan ere, zaintza-ekosistemari eustea ez da soilik familien ardura, ezta soilik zerbitzu publikoena ere; eta ezinbestekotzat jotzen da hiru hanka hauetan eragitea (etxeetan, zerbitzu publikoetan eta komunitatean), beti ere pertsonen bizipenak erdigunean jarritz.

3.2.1. Datu orokorrak

Eustat, Euskal Estatistika Erakundeak 2025eko urtarrilaren 1ean emandako datuen arabera, Gernika-Lumok 16.889 biztanle dauzka eta adineko pertsonen pisuari dagokionez, populazioaren ia laurdena (% 24,7) 65 urtetik gorakoa da, EAEko batez bestekoaren ildotik (% 24,3).



Azken urteotako datuei erreparatuta, **Gernika-Lumoko biztanleria pixkanaka zahartzen ari dela** ikusi dezakegu:

| 65 urte eta gehiagoko biztanleria Gernika-Lumon (%) |             |            |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                     | 2022/01/01  | 2022/01/01 | 2023/01/01  | 2024/01/01  | 2025/01/01  |
| Gizonak                                             | 9,8         | 10         | 10,1        | 10,2        | 10,5        |
| Emakumeak                                           | 14          | 14         | 14          | 14,1        | 14,2        |
| <b>Guztira</b>                                      | <b>23,8</b> | <b>24</b>  | <b>24,1</b> | <b>24,3</b> | <b>24,7</b> |

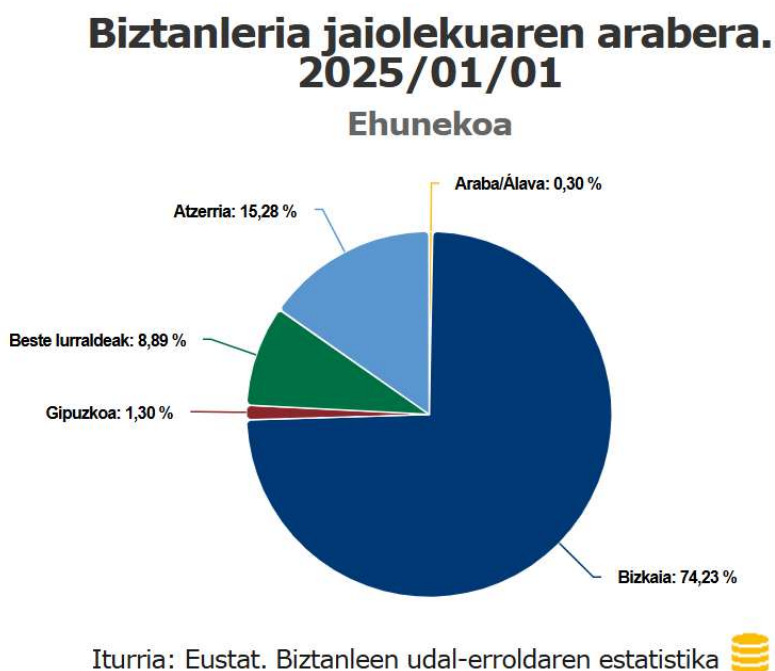


Adin-piramidea sakonago aztertuta, merezi du 80 urtetik gora dauden pertsonen egoerari begiratzea, hauek direlako mendekotasun-maila altuenak dituztenak, bakardade-egoera larrienak pairatzen dituztenak eta baita zaintza behar handiagoak dituztenak ere.

Gernika-Lumon **1.577 pertsonak gainditzen dute 80 urteko langa (biztanleria osoaren % 9 inguru)**. Tarte honetan **feminizazioa nabarmena da** adinean gora goazen heinean. Hala, **85 urtetik gorakoen artean % 65 inguru emakumeak dira**.

Zahartzearen feminizazioari lotuta, ezin dugu zehazki jakin zenbatekoa den bakardade-tasa Gernika-Lumoko 80 urtetik gorako emakumeen artean, baina joera estatistiko eta demografikoek honakoa adierazten dute: Euskadin, 65 urtetik gorakoen artean, bakarrik bizi diren pertsonen % 70 baino gehiago emakumeak dira eta 80 urtetik gora, portzentaje horrek gora egiten du nabarmen. Datu hauen arabera, **Gernika-Lumon 80 urtetik gorako emakumeen artean bakardade-egoerak nahiko zabalduta egongo lirateke, batez ere adinean aurrera joan ahala**.

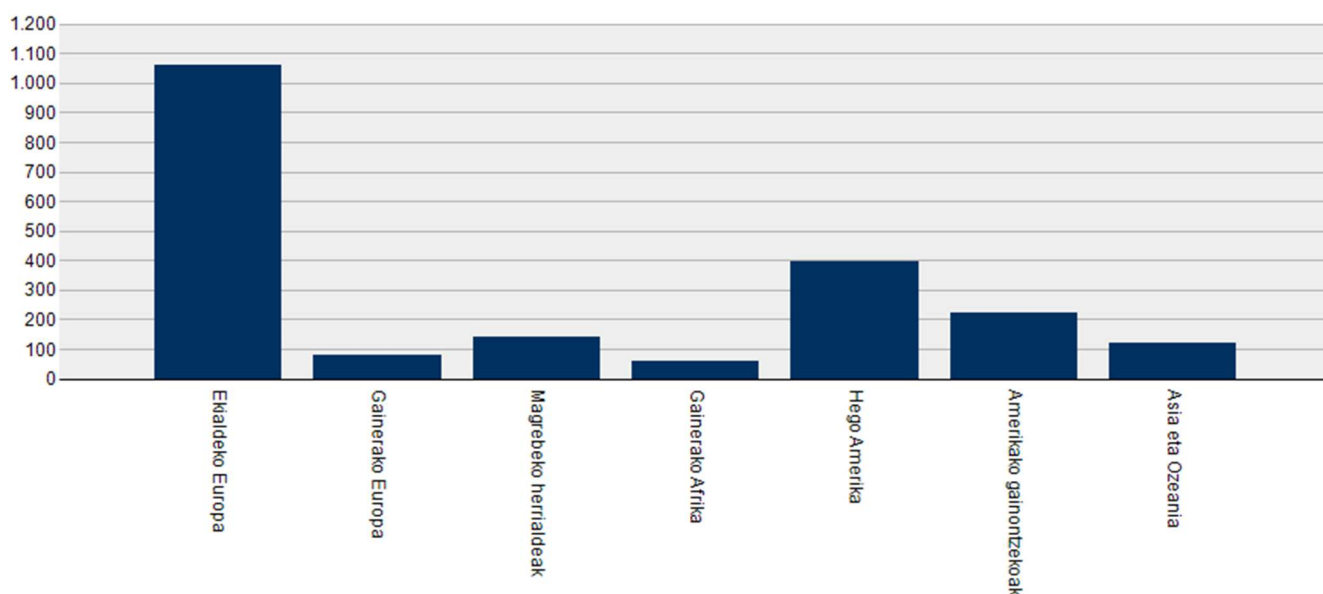
Datu demografikoekin jarraiki, Eustateko 2025eko datuen arabera, Gernika-Lumoko biztanleria jaiolekuaren arabera aztertuta, **herritarren % 15,3 atzerrian jaiotakoa da**.



Datu hauetan sakontzeko Busturialdeko Gizarte-zerbitzuen Mankomunitateko Immigrazio zerbitzuan adierazitako datuetara jo dezakegu: 2025eko urtarilaren 1ean 2.186 atzerritar errolatuta zeuden Gernika-Lumon: herriko biztanleria orokorraren % 12,7 eta Mankomunitateko herrietan bizi diren atzerritarren % 75,5. Espainiako nazionalitatea hartu dutenak gehituta, portzentajea % 15era igotzen da (2.588 pertsona). Nazionalitate nagusien artean **errumaniarrak dira ugariak (ia erdia), ondoren Hego Amerikako komunitateak (Brasil, Kolonbia, Nikaragua) eta Afrikakoak (Maroko, Sahara, Senegal)**.

| GERNIKA-LUMO. Atzerriko biztanleria. <sup>1</sup> (kopurua) |              |              |            |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Nazionalitatea                                              | 2024         | 2025         | aldaketa   |
| ERRUMANIA                                                   | 999          | 967          | -32        |
| BRASIL                                                      | 94           | 105          | +11        |
| MAROKO                                                      | 88           | 91           | +3         |
| NIKARAGUA                                                   | 85           | 91           | +6         |
| KOLONBIA                                                    | 70           | 87           | +17        |
| ARGENTINA                                                   | 80           | 83           | +3         |
| UKRANIA                                                     | 97           | 81           | -16        |
| PAKISTAN                                                    | 56           | 59           | +3         |
| HONDURAS                                                    | 42           | 50           | +8         |
| TXINA                                                       | 55           | 49           | -6         |
| MOLDAVIA                                                    | 52           | 49           | -3         |
| PARAGUAI                                                    | 28           | 41           | +13        |
| SAHARA                                                      | 53           | 38           | -15        |
| PERU                                                        | 26           | 35           | +9         |
| SENEGAL                                                     | 28           | 32           | +4         |
| EL SALVADOR                                                 | 29           | 29           | -          |
| ITALIA                                                      | 28           | 29           | +1         |
| VENEZUELA                                                   | 19           | 27           | +8         |
| PORTUGAL                                                    | 23           | 26           | +3         |
| ESTATU BATUAK                                               | 20           | 23           | +3         |
| BOLIVIA                                                     | 25           | 22           | -3         |
| KUBA                                                        | 17           | 17           | -          |
| GEORGIA                                                     | 16           | 14           | -2         |
| BESTE HERRIAK                                               | 127          | 141          |            |
| <b>OROKORRA</b>                                             | <b>2.157</b> | <b>2.186</b> | <b>+29</b> |

2



<sup>1</sup> Iturria: Busturialdeko Gizarte-zerbitzuen Mankomunitateko Inmigrazio-zerbitzua. 2025/01/01

<sup>2</sup> Iturria: Eustat, euskal Estatistika Erakundea. Biztanleen udal-eroldaren estatistika. 2025/01/01

### 3.2.2. Zaintza-lanen balioa

Zaintza-lanek funtsezko garrantzia dute gizartearen funtzionamendurako, bai arlo sozialean zein ekonomikoan. Hala ere, gaur egun oraindik ere **aitortza sozial eskasa** dute, eta haien balioa sistematikoki gutxietsita dago. Hala, dependentzia egoeratarako zaintza-lanak ikusezin mantentzen dira eta, oro har, familia nuklearraren barruan gisa honetako egoera bat bizi arte ez gara jabetzen zaintzaren garrantziaz.

“Zaintza lanak oso garrantzitsuak dira, beharrezkoa da. Momentua heldu arte ez gara kontziente zenbateraino den beharrezkoa”

**Zaintzaren dimentsio sinbolikora** gerturatu nahian, elkarriketatu guztiei galdera bera luzatu diegu: “Zure ustez, zer esan nahi du pertsona bat zaintzeak?”. Oso profil ezberdineko

pertsonek hartu dutenez parte elkarriketetan, ikuspegi ezberdinak jaso ditugu, baina badaude behin eta berriz errepikatzen diren ideiak.

Oro har, zaintza ez da soilik oinarritzko beharrak asetzearekin lotutako jarduera (higienea, elikadura, mugikortasuna...): zaintzak harreman afektiboak, entzute aktiboa, konpainia, errespetua,

“Ez da bakarrik zaindu, gosaria eman, duxatu... beraiekin egotea, entzutea... guzti hori da zaintza”

gertutasuna eta konpromisoa barne hartzen ditu. Ikusten ez badira ere, horiek dira elkarriketatu askoren ahotan pertsona bat zaintzeaz hitz egiten dugunean gakoak diren alderdiak.

Pertsona askok zaintza prozesu gisa ulertzen dute eta horregatik “akonpainamendu” bezalako terminoak erabiltzen dituzte, zaintzak duen dimentsio humanoa eta emozionala azpimarratzeko.

“No nos gusta el término cuidados. Preferimos hablar de acompañar y apoyar a los procesos.”

Haientzat zaintzea errespetua da, epeltasuna, maitasuna eta enpatia.

“Zaintzea da batez ere errespetua... eta berba horrek duen goxotasuna ez dauka beste batek”

Horregatik azpimarratzen dute

heziketaren bidez balio horiek indartzeko beharra, zaintza-lanen ikusgarritasuna handitzeko eta gizarte osoaren inplikazioa sustatzeko.

“Escuchar lo que necesita esa persona y desde tu posición poder apoyar en esa necesidad.”

Bestalde, zaintzak pertsonaren **ongizatea, autonomia eta duintasuna** bermatzea du helburu, baita **informazioa jasotzeko eta erabakiak hartzeko** espazio seguruak sortzea ere.

Zentzu horretan, zaintza prozesu konplexua da, exigentzia handikoa, eta ez da zertan negatiboa izan behar, baina **baldintza egokirik gabe aurrera eramaten denean prozesu gogorra bihurtzen da.**

Dependentzia-egoeran dauden pertsonen **zaintza familia-eredu nuklearraren menpe** dago neurri handi batean, eta zama hori bereziki **emakumeek** hartzen dute gainera. Sistemak honetara eramaten gaitu: batetik, pertsona bat zaintzeko baliabide publikoak mugatuak dira eta epeak asko luzatzen dira

hauetara sarbidea izateko; bestetik, diru asko behar izaten da merkatu pribatuaren bidez baliabide horiek eskuratu ahal izateko.. Gainera, sozialki presio handia dago zaintza horiek etxetik aurrera eramane daitezen, zaintzea norbanako bakoitzaren arazo pribatu eta pertsonala balitz bezala.

Elkarrizketa gehienetan azaleratu denez, zaintza-lanei balioa emateko, ezinbestekoa da baldintza duinak bermatzea. Bestela esanda, **zaintza-lanen balioa aitortzeko lehen urratsa zaintzaileei lan-baldintza egokiak eskaintzea da**, bai zerbitzuetan bai etxeetan.

“Valorar los cuidados: lo primero, condiciones a las trabajadoras... Eso mismo hay que hacerlo en los domicilios.”

Familiatan egiten diren ordaindu gabeko zaintza-lanez gain, etxeetan zaintza-lanetan ari diren pertsonak ere herriko zaintza-sistemaren oinarri nagusietako bat osatzen dute. Horietako gehienak emakume migratuak izan ohi dira. Gure gizartearen zaintza-beharren oinarrian badaude ere, kasu askotan lan horiek baldintza prekarioetan egiten dituzte, lan-eskubideen inguruko ezjakintasun handiarekin, bai langileen bai enplegatzaileen aldetik ere.

Egoera hori nahiko adierazgarria da ikusteko gure jendartean zaintzari aitortzen zaion balioa zein den; izan ere, oso garrantzitsua den lan bat egiten ari badira ere, honen garrantzia eta beharra aitortua ez dagoenez, hau aurrera eramateko baldintzak prekarioak izan ohi dira: lanordu amaiezinak eta soldata baxuak.

**Instituzio-mailan zaintzari garrantzia aitortzen zaio** eta azken urteetan gero eta pisu handiagoa hartu du ikuspegi honek: Arazo sozial orokor gisa ulertzen dute, eta ez soilik familia eta zerbitzuen arteko ardura-banaketaren ondorio gisa. Zerbitzu publikoetako arduradun politiko zein teknikoei zaintza-lanei balioa nola ematen zaien galdetuta, bereziki azpimarratzen dute gizarte-zerbitzuetako **aurrekontuaren zati esanguratsu bat** dependentzia-egoeran dauden pertsonen zaintzari bideratzen zaiola. Baina hau horrela izanda ere, ez dator herritarren pertzepzio orokorrarekin bat.

Gauzak horrela, gaur egun, zaintza-lanak gero eta merkantilizatuagoak dauden heinean, orduan eta ahots gehiagok defendatzen dute **zaintza-sistema ikuspegi publiko eta komunitario baten ikuspegitik abordatu beharra, ez negozio pribatu gisa**. Hala ere, bide handia dago oraindik norabide horretan egiteko; izan ere, zaintza-zerbitzu asko eta asko pribatizatuta daude, eta beste asko, zerbitzu publikoak diren arren, enpresa pribatuek eramaten dituzte aurrera.

### 3.2.3. Zainduak diren pertsonen egoera eta zaintza-beharrekin lotutako bizipenak

Zaintza-beharrei lotutako bizipenak askotarikoak eta konplexuak dira, eta pertsonen eguneroko bizitza zeharkatzen dute maila emozionalean, sozialean eta ekonomikoan. Arestian aipatu dugun bezala, zaintza ez da logistika edo oinarritzko beharren asetzea soilik; pertsonen duintasuna, autonomia eta ongizate emozionala jokoan jartzen dituen prozesua da. Hori dela eta, **zaintza-beharrek dituzten pertsonak askotan presioa, nekea eta erruduntasuna bizi dituzte, eta ez dira beti entzunak izaten edo erdigunean jartzen sistemaren erabakietan.**

“Muchas veces vienen a la residencia porque están solos y no debería ser así.”

Harreman sozialak eta komunitatea funtsezko elementuak dira zainduak diren pertsonen bizitzetan, pertsona guztien bizitzetan diren bezala. **Bakardadea, bereziki nahi ez denean,**

**arazo larria da,** eta askotan sistemak berak sortu edo areagotzen du.

Bakardade-egoera hauek pertsonen harreman-sareekin lotuta daude. Badaude nahi gabeko bakardadean eta nahiko isolatuta bizi diren pertsonak, bai kalera ateratzeko zailtasunak dituztelako edota beren inguruko pertsonak arrazoi ezberdinengatik desagertzen joan direlako. Eta badaude baita ere, erresidentzietan bizitzeagatik ere, harreman sozial mugatuak edo urriak dituzten pertsonak. Hau da, bakarrik egonagatik erresidentzietara joan diren pertsonen kasuan, bertan jende gehiagorekin egoteko aukera izaten dute, eta oinarritzko zaintza beharrak ere aseta izaten dituzte. Baina badaude erresidentzietan bisitarik jasotzen ez dutenak ere (edo bisita gutxi izaten dituztenak) eta horren ondorioz bertatik ateratzeko ia aukerarik ez dutenak izaten. Honela bada, ikusi dezakegu bakardade-egoera hauek ere askotarikoak izan daitezkeela eta honek inpaktu ezberdina izango duela pertsona bakoitzak hau bizitzeko duen moduaren arabera.

Zaintza-beharrei lotutako diskurtsoetan begirada paternalistak nagusitzen dira oraindik ere, eta horrek zainduak diren pertsonen ahalduntzea eta subjektu aktibo gisa aitortzea zailtzen du.

“Llegan a consulta con mucha necesidad de hablar; con necesidad de un espacio donde puedan compartir.”

Horren aurrean, entzuna izateko beharra eta esperientziak partekatzeko denbora eta espazioak izatea funtsezkoa da.

eta emozionala du: loturak sortzen dira, ziurgabetasuna bizi da, eta eguneroko egoera konplexuek zama psikologiko handia eragiten dute.

Zaintzak, gainera, dimentsio afektiboa

“Familiei entzuten diedanean, argi geratzen da zaintza ez dela logistika soil bat: existentzia bera astintzen du.”

Horrek guztiak agerian uzten du zaintza ereduak berrikusi beharra dagoela, gaur egungo gizartearen behar eta errealitateetara egokitzeko.

## Adineko pertsonen egoera

Adineko pertsonen kasuan, zaintza-beharrei lotutako bizipenak bereziki baldintzatuta daude **bakardade-egoeraren, autonomiaren galeraren eta mendekotasun-mailaren arabera**. Azken urteetan, erresidentzietara heltzen diren pertsonen profila nabarmen aldatu da: gaur egun, **mendekotasun handiagoa eta behar intentsiboagoak dituzten pertsonak** dira nagusi, etxean zaintza jasagarria ez denean iristen direnak. Bestalde, etxeetan mantentzen diren adineko pertsonak ere gero eta **mugikortasun arazo** handiagoak dituzte.

COVID-19ak eragindako pandemia mugarri garrantzitsua izan zen adinekoen egoeran, bakardadea eta isolamendua areagotuz, eta kolektibo honek bizi duen zaurgarritasuna agerian utziz. Horren

“Se genera una visión de la persona dependiente negativa, de carga... Hay que cambiar el mensaje desde abajo.”

aurrean, **mendekotasuna karga gisa aurkezten duten diskurtsoak gainditzeko beharra** azpimarratu dute askok.

“Bakardade sentimendu asko dago, arazo handi bat da. Batez ere jende nagusiaren artean.”

**Bakardadea erronka nagusietako bat da**, batez ere hautatua ez denean. Adineko pertsona askok harreman-sare txikiak eta komunikatzeko zailtasunak dituzte, eta horrek euren ongizate emozionalean eragin zuzena du.

Gernika-Lumon eta Busturialdean **nabarmenak dira hirigunearen eta landa-eremuaren arteko desberdintasunak**. Izan ere, bigarren honetan bizi diren adineko pertsonak askoz ere isolatuagoak daude eta egoera hauei heltzeko beharra ere handiagoa litzake. Badaude egoera honi aurre egiteko teknologia berrien erabileraren alde egiten dutenak; baina, oro har, ez da honen aldeko iritzirik gailendu.

Aitzitik, pertsonak izaki sozialak garen heinean, **adineko pertsonen entzunak izateko beharra azpimarratu dute etengabe**: beste pertsonekin denbora pasatzea, elkarrizketak eta aisialdirako uneak konpartitzea ere funtsezkoa da, oinarritzko beharrak asetzeaz gain.

“Nos han llamado porque había que bajar de las escaleras a una persona, porque tenía que ir al médico y no había con quién”

Egoera horren aurrean, **espazio komunitarioak, elkarguneak eta harremanak sustatzeko ekimenak funtsezkoak** dira, baita laguntza puntualak ere eguneroko beharretarako.

**Zaintzaren prozesu osoan duintasuna eta autonomia mantentzeko nahia** oso presente dago adinekoen diskurtsoetan, nahiz eta askotan karga gisa sentitzeko beldurra agertu. Ildo horretatik azpimarratu dute **zaintza-prozesuetan gertatzen diren trantsizioetan errespetua, entzute aktiboa eta bitartekaritza** sustatzeko beharra. Izan ere, erabaki batzuk gatazka sortu dezakete euren

“Nik nahi izan nuen egoitzara etorri eta nire alabak hori ez zeraman ondo”.

inguruan eta zaintzarekiko harreman afektiboak garrantzitsuak dira, bai zainduen bai zaintzaileen aldetik.

## Dibertsitate funtzionala duten pertsonak

Dibertsitate funtzionala duten pertsonen zaintza-beharrak bizitza-zikloan zehar aldatzen dira, eta trantsizioek bereziki hutsune handiak sortzen dituzte. **Nerabezaroa edo eskolarizazioaren amaiera**

“Cuando termina la escolaridad hay un salto al vacío terrible.”

**une kritikoak dira**, eta askotan baliabide faltak ziurgabetasun handia eragiten du.

**Bakardadea eta harreman sozial ugariak izateko beharra** ere oso presente daude kolektibo honetan. Dibertsitate funtzionala duten pertsonekin lan egiten duten eragileek espazio eta proiektu

“Queremos actividades inclusivas, que se acuerden de nosotros.”

inklusiboen falta salatzen dute. Izan ere, **Gernika-Lumon antolatzen diren gizarte-jardueretan parte hartzeko aukerak mugatuak** dira: dela ordutegiak

euren beharretara egokitzen ez direlako, dela baliabide nahikoa jartzen ez delako. Adibidez, **haurrei zuzendutako aisialdi jarduera gehienetan ez dituzte behar bereziak dituzten haurrak onartzen** kontratatu ohi den begirale-kopurua ez delako nahikoa taldearen beharrianak bermatzeko.

Gainera, kontuan izan behar da dibertsitate funtzionala duten pertsonen artean sedentarismoari lotutako arazoak oso ohikoak izaten direla, aurrez aipatu bezala, jarduera ezberdinetara sarbidea izateko zailtasunak izaten baitituzte, horien artean kirola eta ariketa fisikoarekin lotutakoak. Horregatik **garrantzitsua da bizitza osasungarriak sustatzeko ekimenetara sarbidea** bermatzea.

“No nos gustan las residencias. Apostamos por modelos de convivencia, vida independiente.”

**Etxebizitzari** dagokionez, bizitza independentea eta komunitatean oinarritutako ereduak lehenesten dira, oro har, kolektibo honetako pertsonentzat, eta horretarako programa

propioak egon ohi dira. Baina **Gernika-Lumon bertan emantzipatzeko aukerak oso mugatuak dira dibertsitate funtzionala duten gazteentzat**, eta euren beharretara egokitutako bizilekuetara sarbidea lortzeko ia aukerarik gabe, bizitza independente hori lortzeko zailtasunak gaindiezinak dira askotan.

Horri gehitu behar zaio baliabide ekonomikoen eskasia: dirulaguntzak ez dira nahikoa beharrak asetzeko eta oraindik ere, oinarritzko zerbitzu guztiak ez dituzte bermatuta: adibidez, **eskola-garraioan, herriko haur guztiek ez dute taxi zerbitzua ziurtatuta.**

“Muchas de nuestras personas usuarias son a la vez cuidadoras. Ese doble peso.”

Bestalde, genero-rolek betetzen duten papera ere esanguratsua da dibertsitate funtzionala duten pertsonen artean. Esaterako, **desgaitasun mentala duten emakume askok zama bikoitza dute,**

**zaintza-beharrak izateaz gain, euren gurasoen zaintzaile ere badirelako.** Izan ere, etxetik kanpo lana aurkitzeko izaten dituzten zailtasunen aurrean, familia askotan emakume hauek lan erreproduktibora bideratzeko hautua egiten da, lan-merkatuan txertatzeko alternatiba gisa.



Guzti honi **estigmaren faktorea** gehitu behar diogu; batez ere osasun mentaleko arazoei lotuta. Kolektibo hauekin lan egiten duten eragileen arabera, diagnostiko faltagatik edota gizartean osasun mentalarekin lotutako arazoek duten estigmatizazioagatik, **pertsona asko sistematik kanpo geratzen dira**.

Dibertsitate funtzionala duten **gazteei galdetuta**, orokorrean pozik daude jasotzen duten arreta espezializatuarekin, baina **arrakala handia** nabaritzen dute zentroaren babesaren eta herriaren errealitatearen artean.

Ez dute euren eskariak bideratzeko espaziorik edo elkarriketarako gunerik eta **entzunak izatearen beharra** da etengabe errepikatzen duten eskaria: Beraiek proposamenak egiteko prest daude, baina lehenago entzunak izan behar dira.

Beraiek inork baino hobeto identifikatu dituzte herrian irisgarritasunarekin lotutako mugak (arkitektonikokoak zein kognitiboak). Hala, hainbat izan dira aipatu dituztenak:

- Liburutegira edo herrigunera doazen bideetan **zorua egoera txarrean** dago (harri solteak) eta kotxeak gaizki aparkatuta egoteak gurpil-aulkiak pasatzea eragozten du.
- Herrian ez dago neguko egunetarako **estalitako espazio publikorik**.
- Kirol arloan, Zornotzako eredua jarraituz, kanpoko gimnasia-makinak faltan botatzen dira.
- **Kiroldegia eta Zinema**: Espazioak txikiak dira eta ez daude aniztasun funtzionalera guztiz egokituta.
- **Liburutegian** letra handiagoko eta hizkuntza egokituko liburu gehiago behar dira.
- **Zarata eta argitasun maila** kontrolatu gabeko guneek kaskoak erabiltzen dituzten pertsonak baztertzen dituzte.
- **Semaforoak** soinuarekin egokitzea funtsezkoa da segurtasunerako.
- **Bidebusari dagokionez, Kiroldegira doan lineak ez ditu ordu guztiak betetzen**, erabiltzaileen autonomia mugatuz.
- Trenean ez dago leku nahikorik gurpildun aulkiekin bidaiatzeko.

Lehen aipatutakoaren ildotik, **gazte hauek herritar aktiboak izan nahi dute, ez zerbitzu-hartzaile pasiboak soilik**. Horregatik dibertsitate funtzionala duten pertsonak euren proposamenak eta kexak zuzenean Udalari helarazteko gune egonkor baten beharra sentitzen dute, esaterako, hirigintza aldaketak egin aurretik, euren ikuspuntutik ekarpena egin ahal izateko.

Azkenik, askok azpimarratu da familiei eta hezitzaileei laguntzeko baliabide gehiago bideratzeko beharra.

### 3.2.4. Zaintzaileen egoera eta zaintza-ardurek dakartzaten bizipenak

Zaintza-lanak gure gizartea sostengatzen duten lanetako bat dira, horiek gabe, ezingo genuke aurrera egin. Aurrez aipatu dugun bezala, gainera, lan hauek kasu batzuetan ordainduak izaten dira (profesionalki egiten dira, alegia) eta beste batzuetan familia barruan egiten dira.

Zaintza-lanak nagusiki emakumeen gain egoten dira, eta karga fisiko, emozional eta sozial handia dakarte, bai familia barruan, bai etxeetan kontratatutako langileen kasuan, baita zerbitzu publikoetako profesionalen artean ere.

Jarraian zaintza-ardurek dakartzaten bizipen nagusiak jaso ditugu, hiru eremutan banatuta: familian zaintzen dutenak, etxeko langileak eta zerbitzu publikoetan zaintzen duten langileak. Sakoneko elkarriketen bidez errealitate horien konplexutasuna eta zaintzaileek dituzten beharrak agerian uzten saiatu gara.

#### Familian zaintzen dutenak

Familia da, gaur egun, zaintza-lanak sostengatzeko egitura nagusia. Senide zaintzaileek — gehienetan emakumeek — ardura nagusia hartzen dute, askotan lanaldi murrizketak edo eszedentziak eskatuz, horrek dakarren pobretzearekin batera.

Etxean 24 orduko zaintza behar duen pertsona bat zaintzeak baditu bestelako inplikazioak izan dezakeen kostu edo esfortzu ekonomikoaz gain. Honela bada, pertsona baten zaintzaile nagusiak diren pertsonak iritsi ezinik dabilzan emakumeak izan ohi dira.

Emakume hauek, gainera, kasu askotan ez dute pertsona bakar baten zaintza-ardura izaten, bi edo hiru zaintza-ardura batera, baizik; eta familia barruan zereginen banaketa modu desorekatuan egitean denez, asko tentsionatzen du egoera, pertsona batzuegan pisu handia jarritz.

Gainera, arazo sistematikoa eta errepikakorra bada ere, gizartean zaintzarekin lotutakoak arazo pertsonal bezala bizi dira, eta horren ondorioz pertsona eta familia askok ez dute bizi duten egoeraz hitz egiteko espaziorik izaten. Bestela esanda, zaintzen krisia arazo kolektiboa izan arren, egunerokoan pertsona askok banakako zama gisa bizi dute, **gainkargak, erruduntasunak, nekeak eta isolamenduak eta aitortza faltak eraginda.**

“ Eta, gainera, edadeko pertsonak zaintzeak dakar beste pisu bat, umeei printzipioz ez daukana. Ze umeei guk egitea printzipioz erabakia da, eta, gainera da erabaki ilusionante bat. Edadeko pertsona batek daukazunean familian, egunero zaude dolu prozesu batean. Pertsona hori dago egunero galtzen, galtzen, galtzen, eta ikusten duzu bere bizitzaren amaierarantz doala.”

Zaintza-prozesuen **izaera emozionalari** dagokionez, bereziki adinekoen edo dibertsitate funtzionala duten pertsonen kasuan, **dolu-prozesu jarraitu gisa** bizi dute pertsona batzuek, zaindua den pertsonak gero eta behar gehiago dituela ikusten baitute denboraren poderioz.

Edozein modutan, pertsona bat zaintzea ez da bizipen negatibo horiekin bakarrik lotzen, badira alde positiboak ere: harreman estuak, lotura afektibo sakonak eta ongi zaindu izanaren sentipenak ematen duen ongizatea ere badira azpimarratzen diren ideiak. Azken batean, familia barruan egiten diren zaintza-lanen kasuan maite duten pertsona bat zaintzen egoten dira zaintzaileak, eta horrek badu karga emozional gehigarri bat, bai gogortasunari dagokionean, eta baita horrek ematen duen ongizateari lotuta ere.

Zaintzaile baten egunerokoan **zama fisikoa eta emozionala** pilatzen dira: gauean ere zaintzen egon beharrak eragindako neke kronikoa eta etengabeko alerta egoeran mantentzeak sortzen duen estresa eta antsietatea oso ohikoak dira zaintzaileen artean. Gainera, denboran mantenduak izaten diren zaintza-ardurak izaten diren kasuak dira asko, eta horrek asko zailtzen du zaintzailearen egoera, behar horiei erantzuten jarraitu behar baita, eta lan ordainduan ez bezala, kasu honetan ez dago jai-egunik.

“Ese estrés... tomar una pastilla y ya. Falta espacios para prevenir.”

Aztergai ditugun kasuetan zaintza-lanak exigenteak izaten dira, behar handiak izan ohi dituzten pertsonen ari baikara (kasuan kasu, noski). Behar horiei erantzun behar izateak zaintzaile askori **isolamendua** sentitzea dakarkie, eginbeharretan ematen baitute eguna.

“Etzetik lanera, lanetik etxera eta noizean behin sozializatu.”

Ikusi dugun bezala, beraz, zaintzaile askok aipatzen dute asko kostatzen zaiela beraientzat denbora hartzea. Horrekin lotuta, esperientziak partekatzeko sortu izan diren esperientziak ere izan dira hizketagai; egon izan dira programa eta saiakerak, eta zaintzaileen ongizate emozionalerako positiboak izaten dira, baina denbora faltak asko zailtzen die kasu gehienetan gisa honetako espazioetan parte hartzea.

“Zenbat eta gutxiago urtetan duzun kalera, gutxiago nahi duzu. Ez zara inon eta inorekin enkajatzeko.”

Honela bada, zaintzaileek beraiek ere zainduak izateko beharra dutela adierazten badute ere, **norbere buruaren zaintza bigarren mailan geratzen da** kasu gehienetan. Are gehiago askotan laguntza eskatzeak erruduntasuna sortzen du zaintzaile askorengan; izan ere, errotuta dugu gure senideak zaintzeko dena eman behar dugunaren ideia, eta laguntza eskatu behar izaten denean ideal horri huts egitearen sentsazioa azaltzen da.

“Para las cuidadoras no hay cuidados. Se cuidan solas.”

## Etxeko langileak

Atal honetan aztertuko dugu etxeko langileen egoera, hau da, etxeetan familiek edo norbanakoek modu pribatuan kontratatutako zaintza langile profesionalen egoera, hain zuzen. Kolektibo honen baitan migratutako emakumeak dira nagusi. Zaintza-lanak feminizatutako eta gutxietsitako lanak izateaz gain, jatorriaren eta klase sozialaren arteko gurutzaketak ere eragiten du langile hauen egoeran. **Emakume izateagatik, migratuak izateagatik eta, kasu batzuetan, egoera administratibo irregularrean egoteagatik, zaintza-lanen katebegi ahulenean kokatzen dira etxeko langileak, aukera eta babes-maila txikiena duten egoeretan, alegia.**

Euskal Herrira iritsi berriak diren emakume askok ibilbide luzea egin behar izaten dute etxeko lanen eta zaintzaren arloan, sarritan interna moduan. Izan ere, heldu berri**egoera administratibo irregularrean egoten dira denboraldi batez pertsonak,** eta egoera horretan gure sistemak gaur egun eskaintzen dien aukera gutxietako bat etxeetan erregimen internoan zaintza-lanak egitea izaten da.

“Etxeko langileen begirada / harremana da esplotazioarena maila goren batean. Ezkutuan bizi diren egoerak. Herri honetako baserrietan; etxeetan; interna bezala... oso konplikatuak da jakitea zer gertatzen ari den.”

Erregimen horretan lan-baldintzak ez dira bat ere duinak izaten, baina egoera administratibo irregularrean egonik besterik eskatzeko eskubiderik ere ez dutela sentitzen dute askok, erregularizaziorako bidean tramite bat bailitzan lan horietatik pasatzea eta horrek are zaurgarriago egiten du haien egoera.

“Como no tienes papeles, no tienes derecho a nada... hori ere entzuten dute askotan.”

Zaintzaren sektorean baldintza hobeak bermatzen dituzten lanetara sarbidea izateko, funtsezkoa da **prestakuntza espezializatuaren bidez** profesionaltasun-ziurtagiriak eskuratzea. Aitzitik, errotze sozio-formatibo honetan aurrera egiteko zailtasunak nabarmenak dira:

Alde batetik, tituluen homologazioa egiteko prozesuak asko luzatzen dira. Badaude bere herrialdeetan bestelako prestakuntza edo ikasketak dituztenak ere, baina egoera erregularrean egotea lortuta ere, herrialde jakin batzuetako tituluen homologaziorako zailtasunak oso handiak izaten dira, eta posible diren kasuetan ere oso luzeak. Hori dela eta, zaintzaren sektorean lana badagoenez, hor jarraitzen dute emakume askok, alternatiba askorik gabe kasu gehienetan.

Izan aipatu berri dugun errealitateagatik, edo sektorean lanean jarraitu nahi dutelako, gero eta gehiago dira Lanbide Heziketara jotzeko asmoa duten emakumeak erizain-laguntzaile titulua eskuratzeko. Ikasketa hauek egin ahal izateko, ordea, aurretik gure herrialdean baliagarria izango zaien Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako titulua eskuratu behar dute. Homologaziorako zailtasunak tarteko (nahiz eta kasu guztietan ez den hau arrazoia), titulu hau ateratzeko helduentzako ikasketazentzora jo behar dute eta gaur gaurkoz, Gernika-Lumon kokatuta dagoen CEPA GERNIKA-LUMO HHI-ko plazak beteta daude.

Bestalde, **eskari handia dago titulazio soziosanitarioa eskuratzeko, baina Gernika-Lumon duten eskaintza oso mugatua da.** Bertako lanbide ekimen zerbitzutik urtero antolatzen dira

ikastaroak, baina hauetara sartzeko baldintzak (45 urtetik gorakoak izatea, luzaroko langabetua izatea, etab.) zorrotzak dira, eta asko dira kanpoan gelditzen diren emakumeak.

Errealitate honek emakume migratuak etxe barruko zaintza-lanetan mantentzen ditu, alegia, prekarietatean eta ikusezintasunean, gizartearen erreproduktzioarako funtsezkoak izan arren, behar bezala aitortzen ez diren lanetan.

**Arrazismoa, diskriminazioa eta estigma** ere oso presente daude zaintza-lanetan dabilen emakume arrazializatuen egunerokoan; askotan “gure garaiotako esklabo” gisa izendatzen dira, etxeetan adineko pertsonak heriotzaraino laguntzen dituztelarik, langile gisa ia inongo eskubiderik aitortu gabe, bereziki interna gisa jarduten duten emakumeen kasuan.

“Tenemos a tanta gente que está sin padrón, no tienen acceso a ningún tipo de ayuda pública.”

Emakume hauen **egoera juridiko eta soziala oso prekariora da**: egoera administratibo irregularrean, eskubide urriekin eta beldurrez bizi dira asko. Izan

ere, erregularizazio-prozesuek traba ugari dituzte: aipatu ditugun ikasketen homologazioarako eta lanpostu finko eta duin bat lortzeko zailtasunez, etxebizitza bera ere bada arazo bat. Etxebizitzarekin arazoak izateak eroldara sarbidea izateko ere zailtasunak ekartzen dizkie, eta eroldarik ez izateak **baliabide publikoetara sarbidea izatea eragozten die kasu askotan**. Honek are egoera zaurgarriagoan lagatzen ditu emakumeak, alternatibarik gabe. Egoera zaurgarri horien aurrean, gainera, badaude probetxua atera nahi duten pertsonak.

Aipatu bezala, etxeko lanetan ibiltzen diren emakume migratuentzat **etxebizitza da arazo larrienetako bat**:

“Un señor me cobraba 150 al mes por empadronarme.”

Gernika-Lumon etxebizitzaren gaia bereziki konplikatu da oro har: dauden alokairu garestiak (hein batean turismoaren presioak eragindakoak),

logela partekatuak, erroldatzeko zailtasunak, bizileku prekariorak, kontratu gabeko alokairuak... Orokorrean egoera larria bada, are larriagoa bihurtzen da egoera prekarizatuan dauden emakume migratuentzat.

Horrek guztiak zaintza-lanak are gehiago gogortzen ditu, eta **emergentzia egoeretan** — interna moduan dauden kasuan lan-harremana eteten denean edo zaindutako pertsona hiltzen denean — **hainbat izan dira kale gorrian geratu diren langileak, inongo baliabiderik gabe**.

Langile hauek, pertsona guztiok bezala, **komunitatea eta saretzea behar dituzte**, baina Gernika-Lumon horretarako zailtasunak dituztela azalerratu da diagnostikoan zehar. Aipatu dugun etxebizitzaren arazoa faktoreetako bat da, baina ez bakarra. Izan ere, herri txikietan interna moduan lan egiteak isolamendua areagotzen du: **aisialdirik eza, mugikortasunerako zailtasunak eta gizarte-harremanak eraikitzeko zailtasunak** gure gizartean antolatzekeo dugun moduagatik. Faktore horiek guztiak tarteko, batzuek Bilbon partekatutako etxeren bat izaten dute, eta han egiten dute saretzea eta lanaz kanpoko bizitza.

Etxeko langileen **lan-baldintzak, oro har, oso gogorrak** dira: ordutegi mugagabeak, atsedetik eza eta bizitza pertsonala eta lanekoa etengabe nahastuta. Ordutegi zabalak eta soldata eskasak dira ohikoak. Lan-karga fisikoak (bereziki bizkarreko minak) eta karga emozionalak ere eragin zuzena dute osasunean. Izan ere, zaintzaren alderdi fisikoa ez ezik, pertsonaren sostengu emozionala ere egiten dute askotan, ordu asko partekatzen baitituzte.

“Muchas mujeres viven aisladas y sobrecargadas: Entra a las 8h y tiene 5 h de trabajo... Por la tarde hace 2h más... Entre todo no llega a los 1000 euros.”

“Emocionalmente es duro. Se les coge cariño, aunque les traten mal.”

Laneko testuinguru horretan, askotan lotura afektiboak sortzen dira zaindutako pertsonekin. Nahiz eta kasu batzuetan zaintzaile hauek tratatu ona jasotzen ez

dutela aipatu izan duten, gutxietsiak izaten diren eta abar, pertsonekin harremanetan egoteak eta bere zaintzaren ardura izateak beraien arteko loturak sortzen ditu, eta hori bada lan horrek duen ardura ikusezin horietako bat gehiago.

Hala ere, **zaintzaileentzako zaintzarik ez dago**: ez norbere buruaren zaintzarako denborarik, ez eta baliabiderik ere. Kasu askotan bizirautea izaten da emakume hauen erronka, soldata txikiak izaten baitituzte, eta horrek dirua irabazi ahal izateko ordu asko lan egitera daramatza; izan interna bezala lan egiten dutelako edota izan etxe batean baino gehiagotan eskaintzen dituztelako bere zerbitzuak. Emakume hauetako askok, gainera, jatorriko herrialdera bidaltzen dute irabazitako diruaren parte handi bat, horrek suposatzen duen guztiarekin. Testuinguru honetan, beraz, aisialdirako eta norbere buruarentzako denbora izatea ez da aukera bat izaten, gehienetan denbora faltagatik.

Elkarrizketatan oro har etxeko langileek adierazi dituzten beharrei begiratuta, hauek dira gehien aipatu direnak:

- Laguntza emozionala eta psikologikoa
- Orientazioa eta informazioa, gizarte zerbitzuen bidez bideratu daitekeena (kasu honetan zailtasunak izaten dituzte egoera irregularrean baldin badaude).
- Aholkularitza juridikoa, izan egoera erregulatzeko laguntza, tituluak homologatzekoa...
- Emergentsia egoeretarako baliabideak, hala nola kontratatzailearekin arazo larriak daudenean edo zaindutako pertsona hiltzen denean kale gorrian geratzen direnerako.

Busturialdeko Mankomunitateko Inmigratio zerbitzutik arreta zuzena eta informazio orokorra eskaintzen zaie heldu berriei gai hauen inguruan. Hala, atzerriartasun prozedurak, erroldatzea, osasun txartela, bideraketak eta titulazioen homologazioari buruzko orientazioa ematen dute.

Etxeko langileei dagokionez, 60–70 pertsonako WhatsApp talde baten bidez partekatzen dute informazioa, eta etxeko langileentzat urteroko prestakuntza eta informazio saioak antolatzen dira Etxeko Langileen Elkartearekin elkarlanean. Hala ere, **Gernika-Lumon dauden etxeko langileek zailtasunak dituzte lan-harremanei lotutako aholkularitza juridikoa herrian bertan eskuratzeko** eta askotan Bilbora edo Bizkaiko beste udalerrietara desplazatu behar izaten dira euren lan-eskubideen inguruko informazioa eskuratu ahal izateko.

### Zerbitzu publikoetan zaintzen duten langileak

Zerbitzu publikoetako zaintzaile profesionalek ere lan-baldintza gogorrak dituzte: presio handia, ordutegi zailak eta baliabide eskasak; guzti horri, pertsonak zaintzeak daukan karga emozionala ere gehitzen zaio. Hala ere, txostenean behin baino gehiagotan aipatu dugun bezala, zaintza-lanak ez

“Emozio-karga ez da hitzarmenetan agertzen, baina hor dago.”

dira balioan jartzen gure gizartean, eta hori zuzenean islatzen da, besteak beste, zerbitzu publikoetan lan egiten duten langile askoren (publikoak zein pribatuak) lan-hitzarmenetan.

Haiek ere babes psikologikoa, atsedeen-denborak eta errekonozimendu soziala behar dituzte zaintza-lanak duinak eta jasangarriak izan daitezen. Hain zuzen ere, horretan sakonduko dugu hurrengo atalean, zerbitzuak banan-banan aztertzerakoan.

### 3.2.5. Zerbitzu publikoen eta programen argazki kualitatibo bat

COVID-19ak eragindako pandemiak eragin zuzena izan zuen zaintza beharrei aurre egiteko erabiltzen diren egitura eta zerbitzuetan; oro har, **lehendik zeuden egiturazko hutsuneak areagotu dira**. Batetik, 2008ko krisiaz geroztik ez dira zaintzarekin lotutako lanpostu formalak berreskuratu, asko suntsitu egin baitira, eta sektorean gora doan **pribatizazioak kalteak sortu ditu**, bai arretan, bai langileen baldintzetan ere. Bestetik, gizarte zerbitzuetan **plaza gutxi, baliabide ekonomiko mugatuak, eta koordinazioan gabeziak** daude. Eta azkenik, baliabide asko hiriburuetan zentralizatuta egoteak **lurralde-desorekak** eragiten du.

Zaintza beharrak asetzeko sistema publikoak herritarren eskura jartzen dituen **zerbitzuen helburua bizitza independentea aurrera eramateko zailtasunak dituzten pertsonen bizi-baldintzak hobetzeko laguntza ematea eta euren autonomia pertsonala bultzatzea** bada ere, errealitatea da **baliabide formalak ez datozela bat familien erritmo eta premiekin**. Izan ere, zerbitzuetako erabiltzaileen mendekotasun-maila azkar igotzen ari da eta horrek esku-hartzeak intentsiboagoak eskatzen ditu, sistema bera etengabe tenkatzen delarik. Hau da, lehen dependentzia-maila baxuak zituzten pertsonak ziren zerbitzu sozialetan artatzen hasten zirenak eta ibilbide oso bat egiten zuten. Orain, aldiz, jendartearen zahartzearekin batera, zerbitzuak behar urgenteak dituzten horiei erantzuten egoten dira, eta pertsonak zailtasun gehiago izaten dituzte, sistema diseinatuta dagoen bezala, ibilbide osoa egiteko zerbitzu sozialetan eta hauek eskaintzen dituzten baliabide desberdinetan.

Faktore orokor hauek guztiek Gernika-Lumoko testuinguruan ere isla izan dute eta zerbitzuen gaineko hausnarketa egitera eraman dituzte, bai arduradun tekniko zein politikoak, eta baita eragile sozialak ere.

Datozen lerroetan Busturialdeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak pertsona nagusiei eta mendekotasuna duten pertsonen zuzenduta Gernika-Lumon eskaintzen dituen zerbitzu nagusien gaineko irakurketa egingo dugu hainbat alderdietatik begiratuta: zerbitzuetako arduradun tekniko eta politikoen, erabiltzaileen zein langileen ikuspegiak elkar gurutzatuz, hain zuzen ere.



Bestalde, Osakidetzatik eskaintzen den erizain komunitarioen zerbitzua eta baita hirugarren sektoreak dituen programak ere aipatuko ditugu.

### Oinarrizko gizarte zerbitzuak:

Oinarrizko gizarte zerbitzuak dira gizarte-zerbitzuen **sistema osora sartzeko lehen atea** eta, hortaz, berebiziko garrantzia dute. Bertan diharduten arduradun eta gizarte-langileek oinarrizko gizarte-zerbitzuak herritarren erreferente nagusi gisa kokatzen dituzte eta funtsezkotzat jotzen dute **lehen balorazioa** herritarren beharrianetara eta errealitatera ahalik eta gehien egokitzea, baina era berean erronka handiak dituzte egunerokoan: gizarte-langileak askotan epaituak eta interpelatuak sentitzen

“Jendeak hurbiltasuna nahi du, horren bila gerturatzen dira.”

dira, eta **burokraziak eragindako lan-kargak** esku-hartze zuzenetik denbora kentzen die.

Hala ere, **kalitatea hobetzeko etengabeko ahalegina** egiten dutela azpimarratzen dute.

Prestazioen tramitazioari dagokienez, azpimarratzen dute pertsona nagusientzako tresna inportanteak direla. Baina pertsonen egoerak egun batetik bestera azkar aldatzen diren bitartean **administrazioa geldoa izateak oztopoak sortzen ditu** behin eta berriz. Gainera, **tramite telematikoak zailak egiten zaizkie adinekoei**, eta arlo honetan informazioa eta laguntza behar dutela nabarmentzen dute.

### Busturialdean Zainduz, mendekotasuna duten familiartekoen zaintzaileei arreta eta laguntza emateko programa.

Zaintzaileentzako Zainduz programak 2020ko pandemiaren aurretik ondo funtzionatzen zuen, baina etenaldiaren ondoren **ez da lortu aurreko indarra berreskuratzea**. Gaur egun herritar askok

“Zainduz programa... pandemian galdu genuen pultsua jendearekin”.

zalantzak izan dituzte parte hartzeko eta, hortaz, berraktibazio planak behar dira, komunikazioa indartuz eta formatu malguagoak proposatuz, zaintzaileei atsedenerako eta beren buruaren

zaintzarako aukerak eskainita.

Mankomunitatetik hausnartzen ari dira ea zein izan daitekeen formularik egokiena programa indarberritzeko.

## Etkez etxeko Laguntza Zerbitzua

Etkez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren helburua autonomia murriztuta duten pertsonen eguneroko bizitzako zereginetan laguntzea da; zerbitzu honen bidez erabiltzaileen bizi-kalitatea hobetu nahi da, bere ingurunean bizitzen jarraitzeko aukera emanez.

Gure testuinguruan, Udal bakoitzak araudi propioa du eta zerbitzuaren ezaugarriak arautzen ditu, nahiz eta guztiek 185/2015 Dekretua oinarri izan. Horrek esan nahi du tokiko erakundeetatik (kasu honetan Gernika-Lumoko Udaletik eta Busturialdeko Mankomunitatetik) ateratzen diren araudiak, pleguak eta aurrekontuak erabakigarriak direla Etkez etxeko Laguntza zerbitzuaren baldintzak zehazteko.

Busturialdeko Etkez Etxeko Laguntza Zerbitzuak eta Mankomunitateko arduradunek azpimarratu dutenez, azken urteotan bideratuko aurrekontua igotzearekin batera, gaur-gaurkoz itxaron-zerrendarik ez izatea lortu da.

Erabiltzaileek betetako gogobetetze inkestek erakusten dutenez, **orokorrean oso ondo baloratzen dute**, etxean bertan zaintza jasotzeko aukera ematen baitu. Hala eta guztiz ere, **zerbitzuaren berezko helburu prebentiboa eta adineko pertsonen autonomia luzatzekoa asko lausotu da** eta, praktikan, 0 edo 1. graduako dependentzia-maila duten pertsonen bideratutako zerbitzua izan ordez, nagusiki 2. eta 3. graduako kasu intentsiboak artatzen dira eta **asistentzia maila handiko zerbitzua da**. Kasu horietan, beraz, etkez etxeko laguntza zerbitzuko langileen lana familian zaintza-lan horiek egiten dituzten pertsonen laguntzea izaten da, beraien lan-zama arinduz eta bizigarriago eginez.

Horrez gain, zerbitzuaren intentsitatea, hau da, erabiltzaile bakoitzak jasotzen duen zerbitzuaren **denbora, oso mugatua da** zenbait kasutan, ordu bakar bat ere izatera iritsita. Lizitazioen logikan, **lan-ordu kopuruak kontratatzen dira; alegia, ez da beharrian errealetatik abiatutako erantzuna ematen**. Honen ondorioz, zerbitzuak estaltzen ez dituen beharrei aurre egiteko, **familiek dirulaguntzak eskuratzeko aukera dute, eta sarri diru hori egoera prekarioan dauden etxeko langileak kontratatzeko erabiltzen da**.

Zerbitzua eskaintzen duten langileen ikuspegitik ere, Etkez etxeko Laguntza zerbitzuaren hobekuntza-tartea handia da: langile gutxi dira, lan-zama handia dute, soldata minimoaren azpitik egon diren kasuak egon dira **eta jardunaldi partzialak eta zatikatuak** dira nagusi. Izan ere, ordu-poltsen arabera lan egiten dute eta

“Egunak beti ezberdinak dira. Ordutegia da: 6etatik 22:00etara (...) Ezin duzu planik egin, ordutegiak egun batetik bestera ipintzen dizkizute...”

horrek asko prekarizatzen du langileen egoera.

**Desplazamenduetarako denbora ez zaie lanean emandako denbora bezala aitortzen, eta laneko ordutegiak luzeak eta aldakorrak** dira. Egonkortasun falta horrek eguneroko planifikazioa ia ezinezko bilakatzen du.

“Dependentziaren arabera ordu bete edo ordu eta erdi dituzu beraiekin... ez du denbora ematen.”

Denboraren muga operatiboek zaintzaren kalitatea baldintzatzen dutela aitortzen dute hainbat ahotsek. Askotan

**garbiketa lan gehigarriak egitea eskatzen zaizkie denbora berean;** etxe batzuetan oinarritzko baldintza materialak ere ez daudenean bermatuta.

Hitzarmenen mugak ere agerian daude: ezin dute norbere gauzetarako egun libreak hartzeko aukerarik; jai-egunetan lan egitera behartuta daude eta plantilla mugatua izatean presioa areagotzen du langileengan.

“Neke asko somatzen da... sektore feminizatuek oraindik ez dute balio bera.”.

Faktore guzti hauei zaintza-lanek berez izaten duten **zama emozionala** gaineratu behar zaie. Gainera, etxez etxeko laguntza zerbitzuko langileek bakarka

egiten dute lan eta horrek bakardade sentrazioa areagotzen du. Guzti honek nekea eragiten du, eta ez fisikoa bakarrik; baita emozionala ere.

## Adinekoen Egoitza Zerbitzua

Egoitza-ostatuko programa arrisku edo kalteberatasun handiko egoeran dauden eta M1 mendekotasun-egoeran dauden 65 urtetik gorako pertsonen zuzendutako gizarte-zerbitzua da, bizitoki-, elikadura- eta babes-beharrari estaldura emateko.

Etxez etxeko zerbitzuan ez bezala, erresidentzien kudeaketa eta definizioa Foru Aldundiari eta autonomia-erkidegoari dagokie.

Egoitzei dagokionez, badira konnotazio negatiboa duten lekuak; herritarren zati batek “adinekoen aparkaleku” gisa ikusten ditu, eta alternatiba indibidualagoak nahi izaten ditu bere senidearentzat edo beretzat.

Munduko Osasun Erakundeak gomendatzen du 65 urtetik gorako 100 pertsonako 5 egoitza plaza-plaza egotea lurraldean. Gernika-Lumon bi egoitza daude:

**Kaltzada** Egoitzaren kasuan, 125 plaza eskaintzen dira (plazak publikoak, kontzertatuak eta pribatuak dira; gehienek aldundiaren laguntzaren bat jasotzen dute) eta aipatzekoa da Gernika-Lumoko Udalak patronatuan parte hartzen duela. Instalazioak 2007 urtean berritu ziren azkenekoz.

Egoiliarren profilari dagokionez, Gernika-Lumokoak eta inguruko herrietakoak dira gehienbat. Epe luzerako eta motzerako egonaldiak egin daitezke bertan, eta profil ezberdineko pertsonak daude batean eta besteak: epe luzerako egoiliarrei dagokionez adinekoak eta arazo psikologikoak dituzten pertsonak daude; epe laburreko egonaldiak eskaintzen dira pertsona horien zaintzaile nagusiek oporrak hartzen dituztenean datozen pertsonak edo ebakuntza baten osteko berreskurapenerako zaintza intentsiboagoak behar dituzten pertsonak egon ohi dira. Azken urteetan, egoiliarren profila aldatu egin da, mendekotasun handiagoa eta defizit kognitibo nabarmenagoarekin iristen dira pertsonak.

Kaltzadako kudeatzaileek eurek adierazten duten bezala, egoitza azken baliabidea izan ohi da, adineko pertsona bat etxean, eguneko zentroan edo bestelako laguntzekin moldatu ezin denean. Edonola ere, adierazten dute jendea orokorrean pozik dagoela tratuaekin eta zehazki, balioa ematen diote "Hijas de la Caridad" mojen presentziari eta egiten duten akonpainamenduari, adineko pertsonen zein bere senideek oso ondo baloratzen duten alderdi bat dela aipatzen dute.

Bestalde, nabarmentzen dute esperientzia handiko zentroa dela, baina ahulgunez galdetuta, baliabideak falta direla aipatzen dute. Horrek bat egiten du, hein batean, langileek adierazitakoarekin. Izan ere, Kaltzadako langileek aipatzen dute eguneroko hainbat lan aurrera eramateko pertsonal nahikoa ez dagoela momentu askotan. Horrekin lotuta, aipatzen dute lanerako baldintzak eskasak direla, batez ere baliabide eta denbora faltagatik. Beraien hitzetan, lehen erreferente izan zen egoitza hau eta kalitatean beharrezko joera ikusi dute azken urteotan. Egoitzaren kalitatearen pertzepzioari dagokionez, beraz, ikuspuntu desberdinak daudela ikusi dezakegu.

“90 urteko pertsonak eta 50 urte dituzten gaixoak batera daude eta ez da erraza guztiei batera erantzutea.”

Egoitzan gero eta profil konplexuagoei erantzun behar zaie: osasun mentaleko arazoek gora egin dute eta langileek adierazi bezala, ez dute beti behar besteko formakuntzarik behar espezifikorik horiei erantzuteko.

Bestalde, ordutegi luzeak eta eginbeharrak aurrera ateratzeko presioa eguneroko bihurtu dira langileentzat. Negozioaren logikaren nagusitasunak zaintza-lanaren zentzua desitxuratzen duela

“Zenbat eta egoiliar gehiago eta zenbat eta langile gutxiago hobeto, eta honek lanaren kalitatea asko murrizten du”

sentitzen dute, presiopean lan egin behar izateagatik. Gainera, langileek oro har euren lanarekiko aitortza-falta sumatzen dute.

Eguneroko lana emozionalki eta fisikoki exigentea da: pertsonak altxatu, dutxatu, botikak kudeatu, konpainia eman... eta kontratupeko egonkortasuna izan arren, baldintzak ez dira beste egoitza publiko batzuetan bezain onak (esaterako IFASeko egoitzetako langileen baldintzekin alderatuta).

Egoiliarren ikuspegitik, langile gutxi dago eta askotan ez dira iristen laguntza behar duten

“Pertsona gehiago behar da lanerako; oso auxiliar gutxi daude, gutxienez pertsona 2 gehiago behar dira planta bakoitzean.”

guztiengana, edo ez behintzat behar beste denborarekin. Hau da, oinarritzko beharrak asetzen dira, baina hortik harago behar diren zaintza-lanak egiteko zailtasunak izaten dituzte langileek kasu askotan. Elkarrizketetan asko aipatu da

pertsonaren ohiturak eta duintasuna errespetatzeko beharra, eta egungo egoerak honetan laguntzeko zailtasunak suposatzen ditu.

Zentzu horretan, egoitza herriaren erdigunean egoteak bisitak eta komunitatearekiko lotura errazten ditu, eta autonomia duten pertsonen askatasuna ematen zaie nahi eta behar duten eran herrira ateratzeko. Honela bada, neurri batean kokapenak berak neurri handi batean herriarekiko konexioa eta ikusgarritasuna errazten ditu.

Hala ere, badaude bisitarik jasotzen ez duten egoiliarrek, komunitatean bizita ere bakardade sententzia izaten dutenak, eta bestelako konpainia edo kalitatezko denbora eskaintzea behar dutenak.

Bisitak direla eta, Kaltzadako arduradunek nabarmendu dute zentro irekia dela eta bisita ordutegi malgua dutela (goiz eta arratsalde), eta aipatu dute eskoletatik boluntarioak etortzen direla momentu seinalatuetan, adibidez abestera, eta oso ondo baloratzen dituztela horrelako ekimenak; dena den, gisa honetako jarduerak puntualak izan ez daitezen koordinazio handiagoa falta dela. Zentzu horretan belaunaldien arteko proiektuak asko baloratzen dituzte, baina gehiago sustatu eta landu beharko lirateke.

**Torrezuri** Egoitzari dagokionez, enpresa talde baten parte den fundazio pribatua da eta 27 plaza eskaintzen ditu; erabiltzaile gehienak gernikarrak dira. Arduradunen aldetik pertsonaren duintasunean zentratutako ikuspegia ardatz hartutako ereduaren alde egiten dute eta familiekin elkarlan estuagoa egiteko beharra azpimarratzen dute.

Zentzu horretan, balioan jartzen dute Bizkaiko Foru Aldundiak egoitza aukeratzeko askatasuna ematea erabiltzaileei, nahiz eta onartzen duten kasu gehienetan faktore ekonomikoa erabakigarria dela. Izan ere, familiek egoera sostengatu ezin dutenean egoitzetara jotzen dute Aldundian plaza kontzertatu bat esleitzeko izapideak egiten dituzten bitartean (hilabeteetako prozesua izan ohi da).

Tarte horretan egoiliar horiek plaza pribatua ordaintzen dute bere osotasunean, hilean 3.000 eurotik gorako kostua suposatzen duelarik.

Torrezuri egoitzako langileekin ezin izan dugu elkarriketarik egin baina sindikatuen aldetik nabarmendu dute plantillan aldaketa handiak egoten direla eta lan-baldintza eskasak direla eta.

### Eguneko Arreta Zerbitzua

Eguneko Arreta Zerbitzua mendekotasun arriskuan edota M1 Mendekotasun egoeran dauden pertsonen zuzendutako dago. Beraien arreta-premiekin lotuta dagoen intentsitate baxuko laguntza ematen zaie. Hala nola, gizartetik isolatuta dauden pertsonen egoerak konpentsatzea; pertsonen autonomiarik eusten laguntzea; edo ohiko bizitza-ingurunean mantentzen laguntzea eta sozializatzeko aukerak areagotuz eta erraztuz.

Eguneko arreta zentroei dagokionez, plaza eskasia nabarmena dago Gernika-Lumon: Kaltzadan 18 plaza daude (goizez eta arratsalde bi txandatan erabiltzen da) eta Torrezurin 16 plaza. **Itxaron-zerrendak oso luzeak dira, urtebetera irits daitezke.**

“Eguneko zentrorik sartzen direnerako erresidentziara joateko daude”

Eguneko zentroek berez funtzio prebentiboa bete beharko lukete, eta pertsonen independentzia-maila mantentzen lagundu. Aurrez aipatutako joerari jarraiki, ordea, funtzio prebentibo

hau desitxuratu egin da nolabait, pertsonak nahiko dependentzia-maila altuarekin iristen baitira jada zerbitzu hauetara.

Hala eta guztiz ere, zentroek eginkizun sozial baliotsua dute: egunean zehar beste batzuekin egoteko aukera ematen diete erabiltzaileei, harremanak sortu eta aktibo mantentzen lagunduz; eta aldi berean, pertsona horien zaintzaileei arnasa hartzeko eta bestelako gauzez arduratzeko tarteak izatea ahalbidetzen die.

## Erizain komunitarioak

Gernika-Lumoko osasun-zentroan berriki sortu da erizain komunitarioaren figura, osasun-sistemaren eta komunitatearen arteko **lotura eta elkarlana sustatzeko asmoz**: Osakidetzako lehen-mailako arretatik abiatuta udal-zerbitzuekin, mankomunitatearekin eta pertsonen osasuna sustatzen duten gizarte-erakundeekin koordinatzen da. Zerbitzu honen helburua da herritarren osasuna eta zaintza-beharrak ikuspegi integral, prebentibo eta komunitariotik lantzea.

Zerbitzuaren jarduna batez ere **beharren detekzioan eta tailer praktikoan antolaketan** oinarritzen da: zaintzaileentzako prestakuntza (mugimendua, botikak, lehen sorospenak), pertsona nagusientzako jarduerak (mugikortasuna, fisioterapia), eta sexualitateari edo harreman osasungarriei lotutako saioak (bereziki gazteei zuzenduta). Erabiltzaileen profilari erreparatuta nabarmentzekoa da

“Hay un perfil de mujeres que cuidan a hijos y luego a los padres, y luego se hacen mayores. Es un perfil donde poner el foco porque acaban muy quemadas...”

**zaintzaile diren emakumeen presentzia**, askotan bakardade-egoeran eta norberaren zaintzarako aukerarik gabe daudenak. Zentzu honetan, nabarmena da zegoen hutsune bati erantzuteko sortu den zerbitzua dela.

Zerbitzuaren indargune nagusien artean azpimarratzekoak dira **hurbiltasuna**, erabiltzaileekiko sortzen den **konfiantza**, saretzeko gaitasuna eta abian jarri dituzten jardueren **balorazio positiboa**. Zerbitzuak lotura sozialak sustatzen dituen heinean, bakardade-egoerei aurre egiteko espazioak sortzen ditu.

Muchas tambien necesitan una continuidad en el municipio. No hay nada organizado para que sigan en un grupo... un grupo para hacer ejercicio por ejemplo.

Balorazio orokorra positiboa bada ere, hainbat **ahulgune** identifikatzen dira: baliabide mugatuak dituztela, abian jartzen dituzten ekimenek herrian jarraikortasun falta dutela eta parte-hartzeko zailtasunak. Gainera, osasun-kontsulten denbora-mugak ez du beti

ahalbidetzen zaintzarekin lotutako alderdi emozionalak eta sozialak lantzeko aukera izatea.

Etorkizuneko **erronka nagusiak** dira zaintzaileen zaintza ere erdigunean jartzea, **prebentzioa indartzea**, **bakardadearen aurkako estrategiak garatzea eta parte-hartze komunitarioa handitzea**.

“En comparacion con otros municipios está mas desangelado. Hay falta de participacion o falta de iniciativas”.

Erronka guzti horiei heldu ahal izateko funtsezkoa izango da **erizain**

**komunitarioen figura udal-mailako zein mankomunitate-mailako estrategietan sendotzea** eta elkarlanak abiatzea. Esaterako, eskualdeko beste herri batzuetan martxan jarritako esperientziak Gernika-Lumora ekarri (orientatzaile batekin ibilaldiak antolatzea eta amaieran osasun-pilulak ematea, kasu).

## Hirugarren Sektorea



Gernika-Lumon, hirugarren sektoreko elkarteek saretze-lana egiten dute adinekoen isolamenduari aurre egiteko eta hauen bizi-kalitatea hobetzeko. Hori dela eta, nagusiki, **zahartze aktiboa**, **boluntarioria** eta **laguntza psikosoziala** landu ohi dituzte.

Gernika-Lumon bi dira egoera zurgarrian dauden adineko pertsonei zuzendutako programak abian dituzten hirugarren sektoreko elkarteak:

**Gurutze Gorriak** Gizarte Esku-hartzearen alorreko hainbat programa eta baliabide ezberdin eskaintzen ditu Busturialdean bazterketa arriskuan dauden kolektiboek zuzenduta. Erakundearen azken memoriaren arabera<sup>3</sup>, batetik, baliabide ekonomiko urriak dituzten familien oinarritzko beharrak estaltzea helburu duten hainbat proiektu ditu martxan. Besteak beste, etxez etxeko janari zerbitzua, elikagaien banaketa, edota pobrezia energetikoari aurre egiteko programa. Aipatzekoa da 2024 urtean guztira 276 familia eta 660 pertsona artatu zirela elikagaien banaketaren bidez eta onuradun gehienak Gernikakoak izan zirela (217 familia 2024 urtean). Gernikako udal-langileek elikagaiak Basauritik herrira ekartzen dituzte eta ondoren boluntarioen bidez banatzen da.

Bestetik, kolektibo zehatzei zuzendutako programak dituzte. Esaterako, etorri berriei zuzendutako tailerrak eskaintzen dituzte gaztelania ikasteko eta ingurunea ezagutzeko. Bestalde, zailtasun sozialak dituzten haurrei laguntzeko egitasmoak ere martxan jartzen dituzte (etxerako lanekin laguntzeko edota eskola-materiala zein jostailuak biltzeko kanpainak abian jartzen dituzte). Programa hauetako batzuk elkarlanean garatzen dira eskualdeko eragile eta entitateekin batera (Busturialdeko Mankomunitatea osatzen duten Udalak, Eroski, Maier Kooperatiba edota Gernikako Apnabi aipatzen dira memorian).

Azkenik, adinekoei eta dibertsitate funtzionala duten pertsonei zuzendutako egitasmoak antolatzen dituzte, oro har bakardadea saihestea eta harreman sareak indartzea helburu dutenak: Alde batetik, laguntza eta hurbiltasun zerbitzua dago (kasu gehienetan telefono bidezko jarraipena egiten da astero baina laguntza presentziala ere eman izan da kasu batzuetan, medikuetara laguntzeko edota gestioak egiteko). Horrez gain, jarduerak eta tailerrak eskaintzen dituzte (estimulazio kognitiboa, gimnasia funtzionala, kafe literarioa eta paseo osasungarriak). Era berean, "Voces en Red" programa pilotu bat aipatzen dute adinekoei zuzenduta: gailu elektronikoa instalatzen da erabiltzailearen etxean eta honek, aginduak emanez, aisialdiko eta entretenimenduko hainbat jardura eskaintzen dizkigu, baita musika ere, hitzorduak gogoraraztea, alarmak programatzea eta abar. Azken honi buruz, aipatu behar dugu diagnostiko hau egiteko elkarriketatu ditugun sektoreko beste profesional batzuek zalantzan jarri dutela soluzio teknologikoen eraginkortasuna bakardadeari aurre egiteko.

Azkenik garraio egokituari dagokionez, Gurutze Gorriko garraio egokituak ibilgailuak eskualdeko beste erakunde batzuei ere ematen die zerbitzua, hala nola Gernikako Gorabide elkarteari.

Urte batzuk daramatzate elkarteak ibilgailuaren zerbitzua eskatzen diela gorpil-aulkia erabiltzen duten erabiltzaileak lekuz aldatzeko, eta, horrela, kolektibo batzuek aisialdi-guneetara eta landa-irteeretara joateko duten beharrari ere erantzuna emateko.

Aipaturiko programa hauetan, oro har, profesionalek kudeaketa, balorazio soziala eta koordinazioa zein deribazioa egiten dute, eta boluntarioek zuzeneko jarduerak eta laguntza ematen dute. Izan ere,

---

<sup>3</sup> Memorian jasotzen diren informazio eta datu gehienak Busturialdea osoari egiten diote erreferentzia eta, beraz, ez daude herriz herri desberdinduta.

pertsona boluntarioak dira programen oinarria eta beraiek dira zuzeneko harremana dutenak erabiltzaileekin jarduera askotan.

**Caritasek**, bestalde, beharrian ekonomiko zein sozial larriak dituzten adinekoei zuzendutako arreta eskaintzen du. Batzuetan, laguntza ematen dute etxeko zaintzaileak kontratatzeko kudeaketan edo oinarrizko beharrak asetzeko.

Oro har, hirugarren sektoreak laguntza eta programa ugari eskaintzen baditu ere, baliabideak ez dira nahikoak eskualdeko beharrak asetzeko eta gainera, boluntarioekiko dependentzia handia dute (gehienak adineko emakumezkoak edo jatorri atzeritarra duten pertsonak). Hau da, hirugarren sektoreak kudeatzen dituen programak ez dira zerbitzu publikoen kasuan bezala bermatuta dagoen zerbitzu bat; kasu honetan bere denbora borondatez besteei laguntzeko ematen duten pertsonen lanean oinarritzen dira programa hauek. Hori, bere horretan, ez da zerbait txarra, baina hainbat kasutan erabiltzaileentzat oso oinarrizkoak diren beharrak asetzen ari dira gisa honetako programak, eta oinarrizko behar horiek ez lirateke inguruko borondatezko lanaren gain egon beharko; aitzitik, estrukturalki sostengatuak eta bermatuak egon beharko lirateke.

Idea honekin lotuta, hirugarren sektorean aritzen diren hainbat langileek argi uzten dute lan profesionalizatua behar dela arreta zuzena emateko, eta mankomunitatearekin koordinazioa estua bada ere, hutsuneak oraindik nabarmenak direla.

“Está muy bien tener voluntarios, pero esto es un trabajo.”

### **Dibertsitate funtzionala duten pertsonen zuzendutako zerbitzuak**

Mendekotasun-maila aitortua duten pertsonen zuzendutako zerbitzu espezializatuak Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen ditu. Hala nola, Mendekotasunaren Balorazioa, Eguneko Zentroak eta Egoitzak, Dirulaguntzak (familia-ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoak edo gorpil-aulkiak, ohe artikulatuak, etab. erosteko laguntzak) eta Garraio Egokitua.

Udalaren eskumenekoa da, beraz, hurbileko arreta eta eguneroko bizitzarako laguntza. Mankomunitateko gizarte-zerbitzuen bitartez autonomia mugatua duten pertsonen euren etxean laguntza praktikoa jasotzeko aukera dago Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren bitartez. Bestalde, Mankomunitatearen bidez bestelako zerbitzuen eskaeren tramitazioa ere bideratu daiteke: telelaguntza zerbitzua edota oztipo arkitektonikoak kentzeko dirulaguntzak, besteak beste.

Oinarritzko hainbat kontu administrazio publikotik bideratzen badira ere, Gernika-Lumon, hirugarren sektoreko elkarteak dira, erakunde publikoek diruz lagunduta, egunerokoa funtsezko lana egiten dutenak kolektibo honekin.

**Gorabide, Bizkaiko adimen desgaitasuna duten pertsonen familien elkarteak**, Eguneko Zentro bat kudeatzen du Gernika-Lumon. Herrian presentzia dauka eta aisialdi taldeak kudeatzen dituzte, familiarentzako laguntza eta aholkularitza ere eskaintzen dute.

Boluntarioek lagunduta, dibertsitate funtzionala duten pertsonen euren aisialdiaz gozatzeko eskubidea bermatzeko programak garatzen dituzte Gorabidetik. Hala, familiei zuzendutako "atseden-programak" eskaintzen dituzte, zaintzaileek tarteka deskantsua hartzeko aukera izan dezaten.

**APNABI Autismoaren Espektroko Nahastea (AEN) duten pertsonen familien elkarteak** da, eta batez ere eskualdeko haur eta gazteentzako hezkuntza-laguntza, aisialdi inklusiboa eta lan-munduratzeko bideak jorratzen dituzte: asteburuetakoa aisialdia, oporraldiak, udalekuak, eskola-laguntza, eta abar. Familiei zuzendutako programak ere badituzte: atsedeen-programak, laguntza psikologikoa edota formazio tailerrak, besteak beste.

Gernika-Lumon, APNABIk eguneko zentro espezializatu bat kudeatzen du: Lurgorri Eguneko Zentroa. Zentro hau 2020 urtera arte Bizkaiko Foru Aldundiaren menpeko GUFEk kudeatzen zuen, eta egun hitzartuta dago. Eskola-adina gaintzen duten helduentzako gunea da, eta eguneroko bizitzarako trebetasunak, komunikazioa, gaitasun sozialak eta tailer okupazionalak lantzen dituzte bertan.

**Avifes-ek, Bizkaiko Buru Gaixotasuna duten Pertsonen eta Familien Elkarteak**, buruko osasun arazoak dituztenentzako eta euren familientzako aisialdi programak, laguntza psikologikoa eta gizarteratze tailerrak eskaintzen ditu Busturialdean.

Elkarteak Eguneko Zentro bat kudeatzen du Gernika-Lumon arreta indibidualizatua eta integrala eskaintzeko, autonomia pertsonalaren maila hobetzeko edo mantentzeko, muga funtzionalak konpentsatzeko eta ohiko zaintzaileei laguntza emateko, prebentzio-, gaikuntza- eta laguntza-prestazioen bidez trebatu daitezkeen eta autonomia pertsonalerako eta komunitate-ingurunean parte hartzeko konpetentziak garatu ditzaten.

Bestalde, Gernika-Lumon egoitza fisikorik ez badute ere, **Fekoor, Bizkaiko Desgaitasun Fisikoa edo Organikoa duten Pertsonen Federazioak** herrian zerbitzua ematen du: irisgarritasun arazoetan aholkularitza juridikoa ematen dute eta laguntza pertsonalerako programak kudeatzen dituzte.

Azkenik, lan-munduratzeari eta garapen pertsonalari lotuta, aipatzekoa da beste bi elkartek egiten duten lana ere. Alde batetik, **Gernika-Lumon Lantegi Batuak-ek** lantegia duela eta dibertsitate funtzionala duten pertsonen eskaintako enplegu babestuaren bidez, euren autonomia ekonomikoa eta gizarteratzea sustatzen dutela. Eta, beste alde batetik, **Aspace Bizkaia** garuneko **paralisia** duten pertsonen eskualde-mailako zerbitzuak eskaintzen dizkiela, bereziki errehabilitazioan, eguneko arretan eta hezkuntza berezian zentratuta.

Esku artean duzun diagnostiko partekatua osatzeko hirugarren sektoreko hainbat elkarteetako ordezkariekin talde-elkarrizketa egin dugu eta hauek dira, oro har, solasaldi hartatik jasotako ideia nagusiak:

Esan bezala, hirugarren sektoreko entitateen bitartez artikulatzen da dibertsitate funtzionala duten pertsonen zuzendutako eskaintza; bestak beste, eguneko zentroak, atsedendietarako zerbitzuak, tailerrak edota orientazioa; baina garraio eskasia, itxaron-zerrenda luzeak eta baliabide berezituaren falta dira oztipo nagusiak

**Etxebizitza komunitarioetan eta egoitza egonaldietan oso plaza gutxi** daude; aldi baterako egonaldiak behar dituzten familia edo pertsonak izan ditzakete aukerak sarbidea izateko, baina egonaldi luzeetarako itxaronzerrendak luzeak izaten dira eta ez da erraza izaten plaza bat lortzea.

Kolektibo honetako pertsonen zein haien familiek dituzten beharrei modu egokiagoan erantzuteko hainbat dira **landu edota hobetu beharreko alderdiak**: diagnostiko zehatzagoak, aisialdi eta parte-hartze ibilbideak, asteburuko oporrak, familiei zuzendutako kontziliaziorako programak, udalekuak, izapideak egiteko laguntza eta ikastetxeekin koordinazioa.

**Garraioari** dagokionez, Bidaideak zerbitzuak bi linea eskaintzen ditu —bat Morgatik eta bestea Bermeotik—, baina eskaria handiagoa da. Bidaideak aniztasun funtzionala duten pertsonen euskal erakundea da, irabazi-asmorik gabeko elkarte gisa eratua. Elkartea hainbat jarduera-eremutan egituratzen da eta horietako bat da garraio egokituak. Alegia, furgoneta eta ibilgailu egokituak ditu, gorpildun aulkian doazen pertsonak modu seguruan garraiatzeko. Zerbitzu hau erabili daiteke eguneroko gestioetarako edota aisialdirako eta atez ateko zerbitzua ere eskaintzen dute.

**Familien zama ekonomikoari** aurre egiteko gabeziak ere nabarmenak dira: laguntza ekonomikoak mendekotasun-mailaren arabera ematen dira, baina zaila izaten da desgaitasun-mailaren aitortzan maila altuagoko balorazioak lortzea eta familiek gai hau borrokatu behar izaten dute, pertsonaren beharrei erantzun ahal izateko, horrela bestelako baliabideetara sarbidea izateko (baliabide ekonomikoak zein zerbitzuak). Gernika-Lumon, gainera, ez dago informazio eta laguntza espazio espezifikorik mendekotasun egoeran dauden pertsonen familientzat, eta hori hutsune handi moduan identifikatzen dute.

**Sektoreko langileen egoerari begiratuta, lan-baldintzak orokorrean prekarioak izan ohi dira**: alde batetik, sektore honetan ez dago lurralde-mailako hitzarmenik, beraz, estatuko hitzarmena da dagokiena, eta horrek beste langile batzuen parean baldintza eskasagoetan lagatzen ditu langileak. Gainera, BFAtik zerbitzu hauek ordaindu edota diruz laguntzeko modua plaza bakoitzeko prezioa

zehaztea da, honek “enkante” moduko dinamika bat sortzen du eta eragin zuzena du soldatetan eta langileen lan-baldintzetan.

**Aipatutako zerbitzu eta programen erabiltzei galdetuta**, gazte hauek oso pozik eta **seguru sentitzen dira errekurso espezializatuen barruan baina herri mailan hutsune handia dagoela azpimarratzen dute**: ez dute euren eskariak bideratzeko elkarriketarako gunerik eta **entzunak izatearen beharra** da etengabe errepikatzen duten eskaria.

### 3.2.6. Zaintzaren dimentsio komunitarioa eta herriaren antolaketa

Zaintzaren dimentsio komunitarioa eta herriaren antolaketa ez dira gauza bera, baina **lotura estua dute**, eta herriaren antolaketak asko eragiten du zaintzaren dimentsio komunitarioan. Izan ere, espazio fisiko irisgarriak ez badago, elkargune komunitariorako espaziorik ez badago eta sare sozial sendorik ezean, zaintza-lanak ikusezin bihurtzen dira eta pertsona zaurgarrien autonomia mugatzen da. Horregatik, ezinbestekoa da **zaintza erdigunean jarriko duen herri-eredu bat** eraikitzea, komunitatea aktibatuz eta espazio publikoa zaintza ikusgarri eta partekatuaren zerbitzura jarritz.

Elkarriketetan jasotako iritzien arabera, oro har, Gernika-Lumon **zaintzaren ikuspegi komunitarioa ahula dela ondorioztatu daiteke, nahiz eta horretarako oinarriak eta eragileak existitzen diren**. Zaintza, oro har, esparru pribatura eta familiara mugatuta dago, eta ez da behar bezala lantzen ikuspegi kolektibo eta partekatu batetik. Honela bada, ikusi dugu Gernika-Lumo, beste gauza askotan bezala, honetan ere ez dela salbuespena eta gure gizartearen joera orokorreari jarraitzen diela.

Lehen aipatu bezala, berezi isolatuta daude etxeko eta zaintza lanetan diharduten emakume migratuak. Askok ez dute sare sozialik herrian, ezta biltzeko edo elkar ezagutzeko espaziorik ere.

“Ez dago elkarerik, ez dago bilgunerik; bakarrik daude banaka edo familia txikitan.”

Horrek isolamendua areagotzen du, batez ere kontuan hartuta askok ez dutela Gernika-Lumon bertan bizitzeko aukerarik etxebizitza faltagatik.

Komunitate migratuak existitzen badira ere, ez dago elkargune egonkorrik edo talderik beraien arteko

“Hemen... kuadrillaren sistema da nagusi, eta ez da erraza sartzea.”

sare horiek sendotzeko. Gainera, herriko bizi-dinamika itxia dela azpimarratzen dute prozesuan parte hartu duten pertsonak, “kuadrillaren kultura” nagusitzen da eta hor sartzea zaila

izaten da bertakoak ez diren pertsonentzat.

Hala, zaintza kolektiboa indartzeko beharra behin eta berriz azpimarratzen da: auzolana, saretzea eta elkarren arteko laguntza sustatu behar dira, borondate indibidualetik harago. Ildo horretan, **Sare Feminista** da arlo komunitarioa modu aktiboan lantzeko prest agertu den eragile nagusietako bat, eta espazioak ahalbidetzen dituzten bestelako eragileak ere aipatzen dira (**ASTRA**, besteak beste).

“Espazio seguru eta multikulturalak... pertsonak eroso sentitzeko eta adierazteko modukoak behar dira.”

Halaber, espazio seguru eta inklusiboen beharra nabarmendu da, kultura- eta hizkuntza-aniztasuna kontuan hartuko dutenak.

Azkenik, zaintzaren dimentsio komunitarioa indartzeko aukera erreal gisa ikusten dira jarduera eta belaunaldien arteko espazioak sustatzea, azpiegitura sinpleekin gauzagarriak direnak. Belaunaldien arteko hartu-emanak sustatzeak onurak ekarri ditzake alde guztientzat, eta sareak eta harremanak sortzeko potentzial handia duten dinamikak dira, gainera.

Herriaren antolaketari dagokionez, balorazio orokorra da Gernika-Lumon **irisgarritasuna hobetu dela azken urteetan**, bereziki erdigunean, baina oraindik **gabeziak** daudela zaintza-beharrak dituzten pertsonentzat edota mugikortasuna mugatua dutenentzat. Gabezia horiek pertsona hauen autonomia mugatzen du.

Gernika-Lumo herri laua izatea abantaila gisa aipatzen da, baina oztopo arkitektoniko ugari identifikatzen dira: aldapak, arrapalak falta diren eraikin publikoak, eskailerak dituzten zubi berriak, eta irisgarriak ez diren taberna eta dendak.

Kiroldegian eta anbulatorioan irisgarritasun arazoak daude, arrapala mekanikoak igotzeko bakarrik daude, edo espazio jakin batzuetara iristeko aukerarik ez dagoelako. Horrez gain, kexak udalera helarazi arren, askotan ez direla kontuan hartu sentitzen dute herritarrek (igerilekuan dibertsitate funtzionala duten pertsonentzako garabi bat instalatzea, adibidez).

Auzoen arteko **desberdintasun nabarmenak** ere azpimarratzen dira: erdigunea irisgarriagoa da, eta hobekuntzak egin dira azken urteetan horretarako, gainera; baina auzoetan eta landa-eremuetan hutsune handiak daude. Horrek zaintza-lanak eta autonomia zailtzen ditu, batez ere mugikortasun murriztua duten pertsonentzat.

Mugikortasunari eta garraioari dagokionez, hainbat arazo identifikatzen dira: urrun dauden autobus geltokiak, oinezkoentzako bide desagokiak, eta Gernika eta Lumo arteko lotura eskasa.

“Gernika eta Lumo berez bat dira, baina ez dago batetik bestera oinez joateko aukerarik.”

Horrez gain, bestelako **behar**

**kognitiboak** ia ez dira kontuan hartzen herriaren diseinuan. Seinaletika sinpleagoa, piktogramak eta behar bereziak dituzten pertsonak artatzeko zerbitzu publikoetako profesionalak gaitzea beharrezkotzat jotzen dira, irisgarritasuna ikuspegi zabalago batetik ulertzeko.

Azkenik, azpimarratzen da herriak oraindik **ez duela behar adinako kontzientziarik** zaintzarekin eta autonomiarekin lotutako beharrianen inguruan. Irisgarritasuna ez da soilik azpiegitura kontua, baizik eta **heziketa sozialean eta kulturean ere aldaketak** ematea behar da benetako irisgarritasuna lortzeko.

#### 4. GERNIKA-LUMOKO ZAINZA-EKOSISTEMA: ONDORIOAK ETA ERRONKAK

Jarraian, diagnostikoan aztertutako alderdi guztiak aintzat hartuta, Zaintza Mahaian landutako ondorio orokorrak eta erronkak jaso ditugu, ardatzez ardatz:

##### 4.1. Zaintzak Etxean

Zaintza-lanen balioa aitortzeko, ezinbestekoa da **baldintza duinak bermatzea**, laguntza emozionala eta juridikoa eskaintzea, eta prestakuntza eta saretze aukerak indartzea.

##### Familien egoera:

Zaintza-lanak gehienetan familia barruan antolatzen dira, eta ardura nagusia emakumeek hartzen dute. Horrek dakartza:

- **Gainkarga fisiko eta emozionala:** zaintzaileek neke kronikoa, antsietatea eta dolu-prozesu jarraituak bizi dituzte, bereziki adinekoen kasuan.
- **Isolamendua eta gizarte-harremanen galera:** zaintzaileek ez dute ia aisialdirako denborarik izaten, eta bizipenak partekatzeko eta elkarri sostengua emateko espazio falta nabaria da.
- **Ondorio ekonomikoak:** lanaldi murrizketak, eszedentziak eta pobretze arriskua; familia askok zaintza antolatzeko baliabide ekonomiko eskasak dituzte.
- **Zaintzaileek norbere buruaren zaintzarako aukerarik eza:** laguntza eskatzeak erruduntasuna sortzen du kasu askotan, eta zaintzaileek beraiek ere zainduak izateko beharra dute.

Gauzak horrela, hauek dira Zaintza Mahaian identifikatutako **erronka** batzuk:

- Zaintzaren banaketa desorekatua gainditzea, hau da, zaintza beharrak dituen pertsona baten zaintza nagusiki pertsona batengan erori dadin saihesteko neurriak hartzea.
- Zaintza-lanen feminizazioarekin haustea, gizonen inplikazioa ere sustatuz.
- Zaintzaileen isolamendua apurtzea, saretzeko eta elkartzeko espazio gehiago ahalbidetuz.
- Zaintzaileei norbere burua zaintzeko baliabideak eskaintzea: Zaintzaileek beraiek ere zainduak izateko beharra dute; fisikoki zein emozionaliki.



### **Etxeko langileen egoera:**

- **Migratutako emakumeak** dira gehienak, eta egoera juridiko eta sozial oso prekarioetan aritzen dira.
- **Egoera administratibo irregularrean egoteak** langile hauen zaugarritasuna areagotzen du, hainbat eskubide eta baliabidetara sarbidea zailtzen baitie, eta horrek esplotazio baldintzetan lan egiteko arriskua areagotzen du. Izan ere, egoera irregularrean egoteak eta segurtasun ezak beldurrez bizitzea eta onartuko ez lituzketen lan baldintzak onartzea eragiten die zaintza-lanetan diharduten emakume askori.
- **Etxebizitzarekin lotutako arazoak:** erroldatzeko eta etxebizitza bat alokatzeko zailtasunak.
- **Lan-baldintzak gogorrak:** ordutegi mugagabeak, atsedetik eza, soldata eskasak eta lan-karga fisiko/emozional handia, bereziki erregimen internoan lanean diharduten zaintzaileen kasuan.
- **Isolamendua:** herrian ez dago beraien artean zein herriko beste pertsonekin sartzeko espaziorik; askok Bilbon bilatzen dute babesa.
- **Profesionalizaziorako aukerak mugatuak** dira: atzerriko zenbait herrialdetako titulazioen homologazioa prozesu luzea eta zaila izaten da: prestakuntza-eskaintza oso mugatua da zaintzaren sektorean, baina ezinbestekoa da baldintza hobeak dituzten lanpostuetarako sarbidea izateko.

Gauzak horrela, hauek dira Zaintza Mahaian errealitate konkretu honi erantzuteko identifikatutako **erronkak**:

- Egoera administratibo irregularrean dauden emakumeen eskubideak ahalbidetu daitezen baliabideak jartzea.
- Aholkularitza juridikorako sarbidea izatea herrian bertan langileek euren eskubideen berri izan dezaten, beraien lan-baldintzak duindu ahal izateko.
- Etxebizitzarako sarbidea erraztea: Erroldatzeko eta alokatzeko zailtasunei aurre egitea.
- Profesionalizazioa eta formakuntza bultzatzea: Titulazioen homologazio prozesuak erraztea; prestakuntza eskaintza zabaltzea (titulu soziosanitarioa eskuratzeko baldintzak zabaltzea; helduen eskolan plazak handitzea...).
- Herrian bertan sartzeko espazioak sortzea, isolamendua ekiditeko.

## 4.2. Zerbitzu Publikoak

- Zerbitzu publikoetan ez dago nahikoa aukerarik prebentzioa lantzeko; , baliabide eskasia dago eta ez dago koordinazio nahikorik.
- COVID-19ak eta aurreko krisiek zaintza-sistema publikoa ahuldu dute: plaza gutxi, baliabide ekonomiko mugatuak eta koordinazio eskasa azpimarratu dira.
- Zerbitzuak ez datoz bat familien erritmo eta beharrekin; iristen diren erabiltzaileen mendekotasun-maila gero eta handiagoa da, eta horrek esku-hartze intentsiboagoak eskatzen ditu.
- Zerbitzuen beharra duten pertsonen artean dauden baliabideen inguruko ezagutza mugatua edo ezagutza falta identifikatu da.

### Zerbitzu nagusiak:

- **Oinarrizko gizarte zerbitzuak:** lehen atea dira, baina burokraziak oztopoak sortzen ditu pertsonen dituzten beharrei hauek behar duten erritmoan erantzuteko. Kasu askotan, gainera, kasuak nahiko berandu iristen zaizkie, beraz, lan prebentiboa egiteko mugak dituzte.
- **Etxez etxeko laguntza:** itxaron-zerrendarik ez izatea lortu da, baina zerbitzuaren denbora mugatua da eta zerbitzuaren funtzio prebentiboa galdua dago. Lan-baldintza prekarioak dira langileentzat.
- **Egoitzak:** plaza-kopuru mugatua dute, ratioak altuak eta horrek langileen gainkarga eragiten du. Iristen diren pertsonen gero eta mendekotasun handiagoa dute eta profil konplexuak iristen dira, buru-osasuneko arazoak dituzten pertsonak, kasu. Honek zaildu egiten du egoitzetako langileek egin beharreko lana, eta guztiei kalitatezko denbora eskaintzeko zailtasunak dakartza. Plaza publikoak edota kontzertatuak dauden arren, familiei edota egoiliarrei esfortzu ekonomiko handia eskatzen die kasu askotan.
- **Eguneko zentroak:** plaza eskasia dago eta itxaron-zerrenda luzeak; funtzio sozial baliotsua izan dezakeen zerbitzua da, baina iristen den kasu-mota dela eta funtzio prebentiboa galdua du ia.
- **Erizain komunitarioak:** zerbitzu berria da eskualdean eta erabiltzaileek bere indarguneak azpimarratzen dituzte, bereziki hurbiltasuna eta konfiantza. Hala ere, baliabide mugatuak ditu eta arreta jarraitua bermatzeko bestelako entitate eta eragileekin koordinatzeko zailtasunak
- **Hirugarren sektorea:** Boluntarioen dependentzia handia eta profesionalizazio beharra; koordinazio estua dago, baina hutsuneak nabariak dira.
- **Dibertsitate funtzionala duten pertsonen zuzendutako zerbitzuak:** dibertsitate funtzionala dutenen pertsonentzat eskola garaian badaude baliabideak eta aukerak, baina gero baliabide gutxi daude edo eskualdetik kanpo kokatzen dira. Aisialdian eta garraioan gabeziak daude

eta, oro har, hirugarren sektorearekiko menpekotasun handia dago. Informazio-guneen falta ere nabarmena da. Bizkaiko Foru Aldundiak egoitza eta eguneko zentroen sare bat du desgaitasuna duten pertsonen eta haien familiei laguntzeko, baina eskaintza mugatua da herrian eta itxaron-zerrendak luzea dira.

Gauzak horrela, hauek dira Zaintza Mahaian identifikatutako **erronkak**:

- Zerbitzuak familien beharretara egokitzea, haien erritmoekin eta erabiltzaileen mendeotasun mailarekin bat etortzeko.
- Baliabideak handitzea eta burokrasia gutxitzea.
- Zerbitzu-eredu, programa eta esperientzia berriak pilotatzea, beti ere publikazioaren bidetik.
- Eredu asistentzial hutsetik eredu prebentibo eta komunitariora igarotzeko urratsak ematea.
- Zerbitzu eta baliabide guztien arteko koordinazioa eta deribazioak hobetu arreta integratuaren eredua garatzeko.

### 4.3. Sare Komunitarioak

Zaintzarako sare komunitarioak indartzeko eta norbanakoen autonomia sustatzeko, herriko antolaketa eraldatu behar da, komunitatea aktibatuz eta espazio publikoa zaintzaren zerbitzura jarritz.

- Bakardade egoerek kezka handia sortzen dute eta zaintzaren ikuspegi eta praktika komunitarioa ahula da gizartean, nahiz eta Gernika-Lumon oinarriak existitu.
- Ez dago etorri berrientzako elkargunerik eta herriko dinamikak (kuadrilla-sistema) zaildu egiten du bestelako saretzeak sustatzea.
- Belaunaldi ezberdinen arteko jarduerak eta auzolana sustatzeko ekimenik ez dago apenas, eta dauden horiek puntualak dira.
- Irisgarritasuna hobetu bada ere, badaude hainbat arazo oraindik, zaintza beharrak izan ditzaketen pertsonentzat eta bere zaintzaileentzat egoera konplikatzen dutenak: oztopo arkitektonikoak, seinaleetika sinpleagoa, garraio egokia eta behar kognitiboak kontuan hartzea.
- Dibertsitate funtzionala duten pertsonak ahaztuak izaten dira gure gizartean, hutsune handi bat dago beraiei beharrei erantzuteko, ikusgarri egiteko...

Gauzak horrela, hauek dira Zaintza Mahaian identifikatutako erronka batzuk:

- Herriko antolaketa eraldatzea komunitatea aktibatzea errazteko.
- Bakardade egoerei irtenbidea emateko bideak antolatzea, profil desberdinen errealitateak eta beharrak kontuan hartuta.
- Auzolana eta belaunaldien arteko ekintzak eta guneak bultzatzea.
- Dibertsitate funtzionala duten pertsonen elkarrekin elkarlana sustatzea herrian antolatzen diren ekimenetan, integrazioa eta autonomia sustatzeko.
- Gernikako irisgarritasuna hobetzen jarraitzea: oztopo arkitektonikoak ezabatzea, seinaleetika erraztea eta behar kognitiboak kontuan hartzea.
- Baliabide eta eragileen arteko ezagutza eta elkarlana sustatzea, baliabideak optimizatze aldera, deribazioak eta saretzeak egiteko aukerak hobetuz.

## 5. ERANSKINAK

### E.1. Zaintza mahaiaaren rola

Atal honetan jaso dugu elkarriketetan parte hartu duten eragileen begietan zer den zaintza mahaia, ze aukera ekartzen dituen eta zein izan daitezkeen hurrengo urteetarako lanketak. Gogoeta hauek Zaintza Mahaia aintzat hartu beharko ditu hurrengo urratsak irudikatzeko, hala nola, bere funtzioak zehaztu, eragile edota norbanako gehiago parte hartzera gonbidatu, ekintza-plan bat irudikatu...

Sakoneko elkarriketen amaieran Zaintza Mahairi buruz ere galdetu dugu; izan ere, egitura berria da herrian eta bere jarduna hasi berri du. Beraz, zaintzaren bueltan bere jarduna aurrera eramaten duten eragileek nola ikusten duten jakitea bereziki interesgarria da. Oro har, Zaintza Mahaia **aukera estrategiko gisa antzematen da** Gernika-Lumon zaintza-ekosistema hobetzeko bidean.

Hala, Zaintza Mahaia zaintzaren inguruko gobernantza-espazio estrategikoa gisa ikusten da, herriko bizi-baldintzak hobetzea helburu duena. Elkarriketatuen ikuspegitik, Mahaiaaren zeregina ez litzateke diagnostiko bat egitea, baizik eta zaintza herri ikuspegitik lantzeko espazio partekatua eraikitzea, arduradun politikoek, teknikoez eta herriko eragileek elkarrekin hausnartu eta erabakiak hartzeko.

Hasteko, helburu nagusia egoeraren irakurketa partekatua egitea izango litzateke, zaintza erantzukizun kolektibo gisa kokatuz. Hortik abiatuta, Zaintza Mahaiaaren funtzio nagusietako bat **planifikazio estrategikoa eta koordinazioa izango litzateke**.

“Inoiz inork ez du pentsatu honetan... super garrantzitsua da.”

horrela ulertzen dute.

Diagnostikoak zaintzaren errealitatea ikusarazi, hutsuneak identifikatu eta instituzioak interpelatzeko balio duela ikusten dute, lanketaren abiapuntu gisa, beraz.

“Kontzientzia hartzen duzunean ezin duzu atzera egin; aldaketa egiteko proposamenak etorri behar dira.”

identifikatutako lanketak izan beharko dituela lantzeko erronka gisa.

Zaintza Mahaia **eragileen arteko topagune** gisa ikusten dute elkarriketatu gehienek: **Elkar ulertzeko espazioa eraikitzaile bat**, hausnarketa pertsonala, teknikoa eta politikoa uztartuko dituen, herri ikuspegitik.

“Hausnarketa pertsonala, teknikoa eta politikoa egitea dagokigu... zelan nahi dugun gure bizitza, gure zahartzaroa eta gure herria eratu.”

Gauzak horrela, **esku artean dugun diagnostikoa ez da helburu gisa ulertzen**, baizik eta **eraldaketarako abiapuntu gisa**. Xede horrekin sortu den proiektua izan da, eta eragileek ere

Bestalde, astotan azpimarratzen da diagnostikoak **erantzun praktikoak** ekarri behar dituela, eta ezinbestekoa dela **jarraipen egituratua** izatea. Hau da, zaintza mahaia bertan

## E.2. Proposamenak

Diagnostiko hau osatzeko egin ditugun elkarrizketetan iritziak, bizipenak eta ikuspegiak partekatzeaz gain, **proposamen zehatz asko aipatu dituzte gure solaskideek**. Aitzitik, esku artean duzun txostena diagnostiko bat izanik, Zaintza Mahaiaren esku geratuko da jasotako guztia aintzat hartuta ekintzetara jaisteko ariketa lantzea.

Esan bezala, hau **ekintzen zerrenda soila** da. Alegia, ez dago erronka edota helburu zehatzen arabera antolatuta eta **ez da Zaintza Mahaiaren landu**. Halere, informazio hau baliagarria izan daiteke etorkizunerako eta horrexegatik eranskin gisa txertatzen ditugu proposamenok jarraian:

### Adineko pertsonen egoera hobetzeko proposamen batzuk

- Adinekoen beharrak ezagutzeko inkesta sistematikoak egin.
- Bakardade ez-bilatua identifikatzeko eta arintzeko programa egonkorrak sortu.
- "Paziente aktiboa" eta osasun mentaleko programak indartu.
- Ariketa fisikorako orientatzailea sortu eta erizain komunitarioekin taldeko paseoak antolatu "osasun pilulak" emateko.
- Umeen jolaslekuetan adinekoentzako ariketa-guneak jarri eta belaunaldi ezberdinak elkartzeko proiektuak sortu.

### Dibertsitate funtzionala duten pertsonen egoera hobetzeko proposamen batzuk

- Herriko jai eta ekitaldietan pertsona hauek kontuan hartzea eta aisialdi inklusiboa sustatzea.
- Oztopo arkitektonikoak kentzea (arrapalak kiroldegian eta anbulatorioan).
- Seinaletika kognitiboa (piktogramak) eta espazioen diseinu egokitua udal-ekipamenduetan.
- Paseatzeko ibilbide erosoak bermatzea aulki gurpildunentzat.
- Etxebizitza komunitarioak sustatzea eta etxebizitza-irtenbide indibidualagoak bilatzea hala behar dutenentzat.
- Udalekuetan parte-hartzea bermatzeko baliabideak jartzea (begiraleak, garraioa) eta elkarteekin elkarlanean antolatzea.
- Dibertsitate funtzionala duten pertsonen laguntzaileek sarrera ordaindu behar ez izatea ekitaldietan.
- Eskola-garraioan garraio egokitua bermatzea.
- Langile publikoei formazioa ematea eta arreta-protokolo espezifikoak diseinatzea.

#### Familian zaintzen duten pertsonen egoera hobetzeko proposamen batzuk

- Zaintzaileei atsedeen hartzeko "arnasguneak" edo programak indartzea Gernikan bertan.
- Entzute-espazioak eta laguntza psikologikoa eskaintzeko programak sustatzea.
- Zaintza lan konkretu batzuetan trebatzeko tailer praktikoak eskaintzea hala behar duten senideei: mobilizazioak, kudeaketa emozionala...
- Tramiteak, laguntza ekonomikoak eta zerbitzuak kudeatzeko informazio-gune argiak identifikatzea eta laguntza administratiboa eskaintzea.
- Zaintza-lanetan diharduten emakumeentzako sostengu edota ahalduntze taldeak eta tailerrak antolatu, haurtzaindegi-zerbitzua eskainiz parte-hartzea errazteko.

#### Etxeke langileen egoera hobetzeko proposamen batzuk

- Lan-baldintzak duintzeko neurriak hartzea: langileei aholkularitza juridikoa eskaini; familiei lan-baldintzen eta kontratatzaile gisa dituzten betebeharrak buruzko informazioa helarazi...
- Etxe barruko langileen kaleratzeak gertatzen direnean, egoera zaurgarrian geratzen diren langileentzako etxebizitza eta larrialdirako baliabideak bermatu.
- Egoera administratibo irregularrean dauden pertsonen erroldatzea ahalbidetzeko neurriak eskaintzea (errolda soziala).
- Erroldatzearen inguruko gehiegikeriak eta praktika irregularren aurrean neurriak hartzea.
- Etxebizitza-alokairuaren sarbidea erraztea (horretarako etxe hutsak baliatu, prezioak mugatu, eta turismoaren presioa kontrolatu).
- Langile etorkinentzako laguntza eta babes egitura komunitario espezifikoak sustatzea herrian bertan.
- Diagnostiko bat egitea proposatzen da profesionalizazioa zabaltzeko.

#### Gizarte-zerbitzu publikoak hobetzeko proposamen batzuk

- Zerbitzuen mapa argia osatzea eta herritarrei funtzionamendua azaltzea.
- Lehen arretara baliabide gehiago bideratzea: denbora eta profesionalak.
- Etxez etxeke laguntza zerbitzua indartu (langile gehiago eta haien lan-baldintzak hobetu; zerbitzuaren intentsitateak handitu eta modalitate gehiago eskaini) eta zerbitzuaren publikazioa aztertu.
- Eguneke zentroen eskaintza handitzea eta plaza gehiago sortzea.



- Egoitzetan plantillak indartzea (ratioak eta arreta-denborak hobetzea); pertsonarengan zentratutako eredua garatzea, tratu duina eta familia-loturak lehenetsiz; jarduera inklusiboak eta interakzio soziala sustatzea egoitza barruan.

#### Ikuspegi komunitarioan sakontzeko proposamen batzuk

- Zaintza-mahaiaren bidez herri-mailako diagnostikoaren emaitzak herritarrekin partekatzea.
- Auzo-sareak, elkarlaguntza taldeak eta auzolana (bereziki gazteena) egituratzea eta sustatzea.
- “Astra” bezalako guneak zaintzea eta garatzea, komunitatea trinkotzeko.
- Zaintzari buruzko diskurtso positiboa lantzea eta zaintzaren balioa eta beharrak gizarteratzeko ekimenak lantzea.
- Zaintza ikusgarri egingo duen eta erraztuko duen hiri-antolaketa bultzatzea.
- Teoriatik harago, proposamenak eguneroko praktikara eta errealitatera lurreratzea.